AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

GASTROENTEROLOGÍA

Hepatología

26 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Esófago y Estómago

★★☆ 1.1. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett 3
★★☆ 1.2. Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori 4
★★☆ 1.3. Disfagia y Trastornos Motores del Esófago 5
★★★ 1.4. Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico 6
★☆☆ 1.5. Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico GES 7
★☆☆ 1.6. Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino 8

02 Intestino y Colon

★☆☆ 2.1. Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable 9
★★★ 2.2. Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación 10
★★★ 2.3. Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa 11
★★★ 2.4. Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn 12
★★☆ 2.5. Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje GES 13
★☆☆ 2.6. Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula 14

03 Hígado

★★★ 3.1. Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico 15
★★☆ 3.2. Hepatitis Aguda y Crónica GES 16
★★☆ 3.3. Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal 17
★★☆ 3.4. Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares 18

04 Vía Biliar y Páncreas

★★★ 4.1. Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis GES 19
★★☆ 4.2. Pancreatitis Aguda 20

05 Abdomen Agudo y Urgencias Digestivas

★★★ 5.1. Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis 21
★☆☆ 5.2. Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular 22
★★★ 5.3. Hemorragia Digestiva Alta y Baja 23
★☆☆ 5.4. Cuerpo Extraño Digestivo 24

06 Gastroenterología y Cirugía Pediátrica

★★★ 6.1. Diarrea Aguda y Crónica en el Niño 25
★★☆ 6.2. Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño 26
★★☆ 6.3. Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones 27
★☆☆ 6.4. Trauma Abdominal y Torácico 29

Números que tienes que saber 30
Fármacos de primera línea 32
GES de la especialidad 33
Plan de repaso de 7 días 35
Índice por prioridad ★ 36

BLOQUE 01 · ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

1.1 Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett

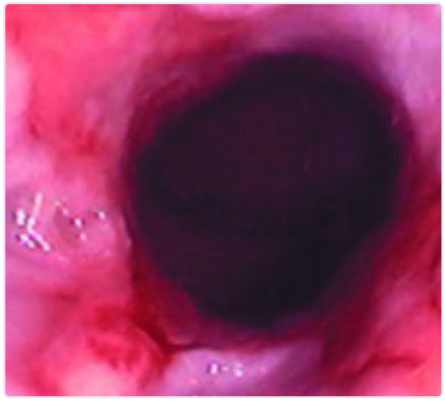
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
9 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.027 Reflujo gastroesofágico — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Endoscopía digestiva alta y baja

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Pirosis + regurgitación típicas, sin alarma y < 50 años**: diagnóstico clínico y prueba con IBP; no se endoscopia de entrada.
- El IBP se toma en ayunas, **30–60 min** antes de comer. Los antagonistas H_2 están obsoletos y no se combinan con IBP.
- Signos de alarma (disfagia, baja de peso, anemia, hemorragia, síntomas nocturnos, > **50 años**, > **5 años** de pirosis) obligan a endoscopía.
- **Barrett** = biopsia con metaplasia intestinal. Lo que decide la cirugía es la displasia, no la metaplasia — son conceptos distintos.
- No se erradica H. pylori por ERGE; sí es obligatorio erradicarlo en úlcera péptica y linfoma MALT.



ESOFAGITIS EROSIVA
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 26

ALGORITMO · ERGE Y ESÓFAGO DE BARRETT: ¿CUÁNDO ENDOSCOPIAR?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

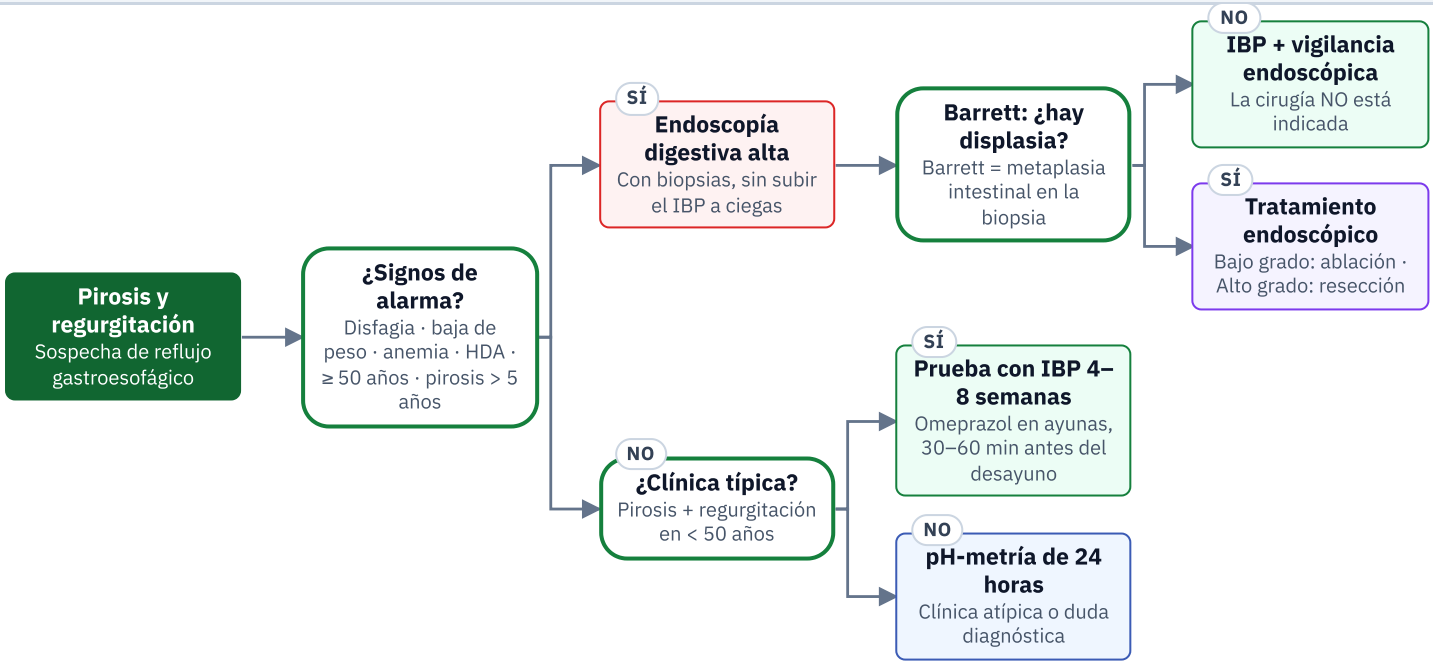


TABLA 1.1 · ERGE — DECISIONES CLAVE QUE SE PREGUNTAN EN EL EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Pirosis típica, < 50 años, sin alarma	Prueba con IBP 4–8 semanas	Pedir endoscopía de entrada
Pirosis + disfagia o baja de peso	Endoscopía digestiva alta	Subir la dosis de IBP sin estudiar
Duda diagnóstica / clínica atípica	pH-metría de 24 h	Tratar empíricamente de forma indefinida
Barrett con metaplasia sin displasia	IBP + vigilancia endoscópica	Indicar cirugía por el hallazgo de metaplasia
Barrett con displasia de alto grado	Resección endoscópica / esofagectomía	Solo aumentar IBP y controlar

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Línea Z más de 2 cm sobre el diafragma	Hernia hiatal por deslizamiento	Llamarlo Barrett

REGLA DE ORO — **Típico, joven y sin alarma** — Diagnóstico clínico + prueba con IBP

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **6, 9–10** (págs. 8–9) · solucionario págs. 20–21.

Clase 1.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

1.2 Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori

★★☆
PRIORIDAD MEDIA
13 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.030 Úlcera péptica — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Dispepsia · Endoscopía digestiva alta y baja · Endoscopía digestiva alta · Antiinflamatorios no esteroidales y tracto gastrontestinal

LO QUE TE PREGUNTAN

- El omeprazol trata el reflujo; la úlcera péptica se trata erradicando H. pylori. Sin erradicación, la úlcera recidiva en el **90 %**.
- Toda úlcera duodenal se erradica aunque el test de H. pylori sea negativo (falso negativo frecuente con IBP o sangrado reciente).
- Toda úlcera gástrica exige biopsia del borde para descartar cáncer y endoscopía de control tras el tratamiento.
- **Primera línea**: IBP + amoxicilina + claritromicina por **14 días**. Segunda línea: cuádruple con bismuto, sin claritromicina.
- **Linfoma MALT gástrico**: se trata con erradicación de H. pylori, no con quimioterapia. En la ERGE no se erradica.
- **Úlcera perforada**: radiografía de tórax de pie (neumoperitoneo) y cirugía urgente; la endoscopía está contraindicada.



ÚLCERA DUODENAL
Harrison 21.ª ed., p. 2430

ALGORITMO · DISPEPSIA Y ÚLCERA PÉPTICA: ESTUDIO Y ERRADICACIÓN

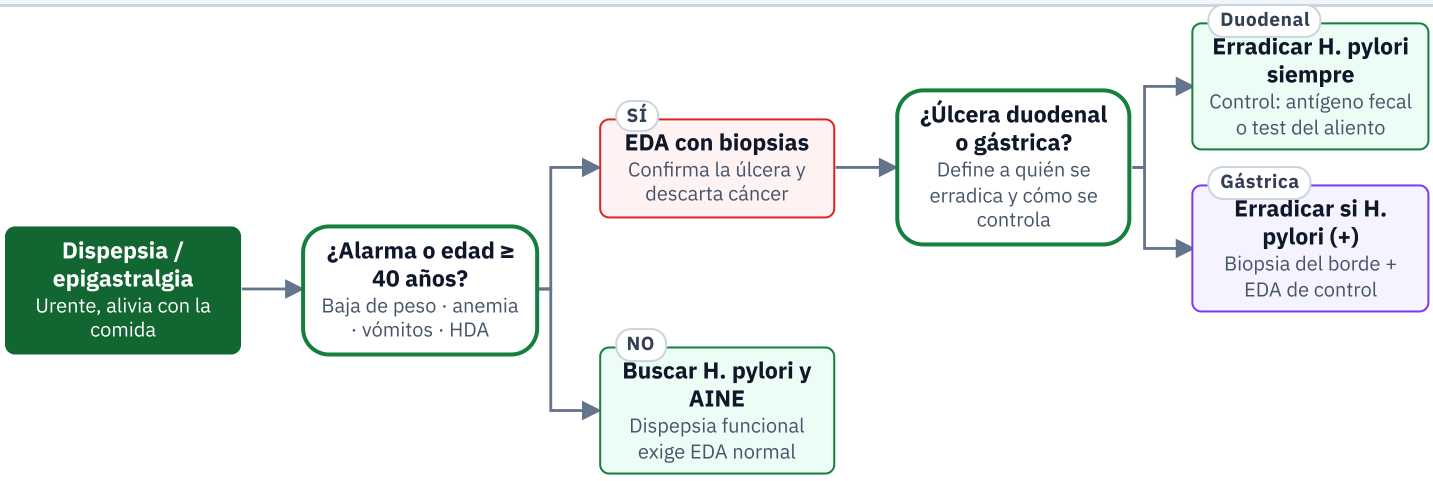


TABLA 1.2 · ÚLCERA PÉPTICA — A QUIÉN SE ERRADICA Y CÓMO SE CONTROLA

SITUACIÓN	¿ERRADICAR H. PYLORI?	CONTROL POST-TRATAMIENTO
Úlcera duodenal (cualquiera)	Siempre, aunque el test sea negativo	Antígeno fecal / test del aliento a las 4 sem
Úlcera gástrica con H. pylori (+)	Sí	Endoscopía (cicatrización + biopsias)
Úlcera gástrica con H. pylori (–)	No	Endoscopía de control
ERGE con H. pylori (+)	No — no hay asociación	No aplica
Linfoma MALT gástrico	Sí — es el tratamiento (no quimioterapia)	Endoscopía seriada

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

SITUACIÓN	¿ERRADICAR?	CONTROL
AINE crónico de riesgo	Sí, si hubo úlcera; AINE + IBP	Sucralfato o anti-H2: no protegen

REGLA DE ORO **Alarma o 40 años o más** — Endoscopía con biopsias

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **7, 11–12, 74** (págs. 9, 18) · solucionario págs. 20–21, 29.

Clase 1.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

1.3 Disfagia y Trastornos Motores del Esófago

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.013 Disfagia — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Acalasia · Cáncer del esofágo · Divertículos esofágicos · Tránsito esófago-estómago-duodeno · Trastorno de deglución

LO QUE TE PREGUNTAN

- Disfagia lógica (sólidos → líquidos, progresiva) = obstrucción = cáncer de esófago → endoscopía con biopsia.
- **Disfagia ilógica (líquidos desde el inicio, fluctuante)** = trastorno motor = acalasia o esclerodermia → manometría.
- **Acalasia**: regurgitación no ácida y neumonías aspirativas; tratamiento de elección = miotomía del EEI.
- **Disfagia alta + halitosis** = divertículo de Zenker → esofagograma con bario, tratamiento quirúrgico.
- Los bloqueadores de calcio relajan el EEI (útiles en acalasia inicial) pero producen reflujo; no se usan para tratar la ERGE.



CÁNCER DE ESÓFAGO
Harrison 21.ª ed., p. 2460

ALGORITMO · DISFAGIA: ¿OBSTRUCCIÓN O TRASTORNO MOTOR?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

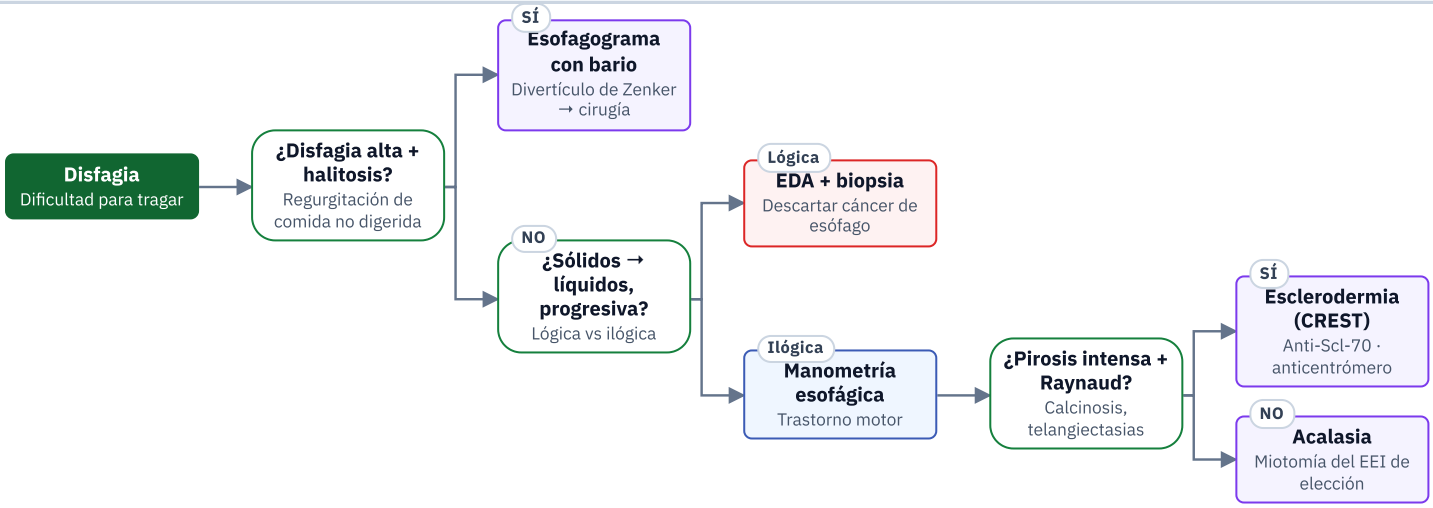


TABLA 1.3 · DISFAGIA — PATRÓN CLÍNICO Y EXAMEN DE ELECCIÓN

CUADRO	CLAVE CLÍNICA	EXAMEN DE ELECCIÓN
Cáncer de esófago	Disfagia lógica progresiva + baja de peso	Endoscopía digestiva alta + biopsia
Acalasia	Disfagia ilógica baja + neumonías aspirativas	Manometría esofágica
Esclerodermia (CREST)	Disfagia ilógica + pirosis + Raynaud/calcinosis	Manometría + anticuerpos (anti-Scl-70, anticentrómero)
Divertículo de Zenker	Disfagia alta + halitosis + regurgitación	Esofagograma con bario
Anillo de Schatzki / estenosis péptica	Disfagia lógica intermitente a sólidos, sin baja de peso	Endoscopía (permite dilatar)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CUADRO	CLAVE CLÍNICA	EXAMEN DE ELECCIÓN
Disfagia orofaríngea	Tos al tragar, voz húmeda, neumonías aspirativas	Prueba de agua; suspender vía oral y derivar

REGLA DE ORO **Lógica: EDA con biopsia** — Obstrucción, descartar cáncer

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **4, 13–14** (págs. 8–9) · solucionario págs. 20–21.

Clase 1.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

1.4 Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico

★★★ PRIORIDAD ALTA
14 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.030 Úlcera péptica — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Perforación esofágica - Mediastinitis · Esofagitis cáustica · Peritonitis · Radiografías contrastadas (EED, trànsito intestinal, enema baritada y pielografía).

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Úlcera perforada**: dolor en puñalada + abdomen en tabla → Rx tórax de pie (neumoperitoneo) → cirugía urgente. Endoscopía contraindicada.
- **Perforación esofágica**: dolor torácico + vómitos + enfisema subcutáneo → Rx/TAC tórax (neumomediastino). Causa más frecuente: iatrogénica.
- Boerhaave (vómitos → perforación) ≠ Mallory-Weiss (vómitos → hematemesis).
- **Ingesta de cáustico**: endoscopía precoz define la conducta. Carbón activado y lavado gástrico están contraindicados.
- Si el enunciado ofrece suero + antibióticos + IBP + cirugía en una perforación, la respuesta es siempre la cirugía.



NEUMOPERITONEO
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 65

ALGORITMO · URGENCIAS DEL TUBO DIGESTIVO ALTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

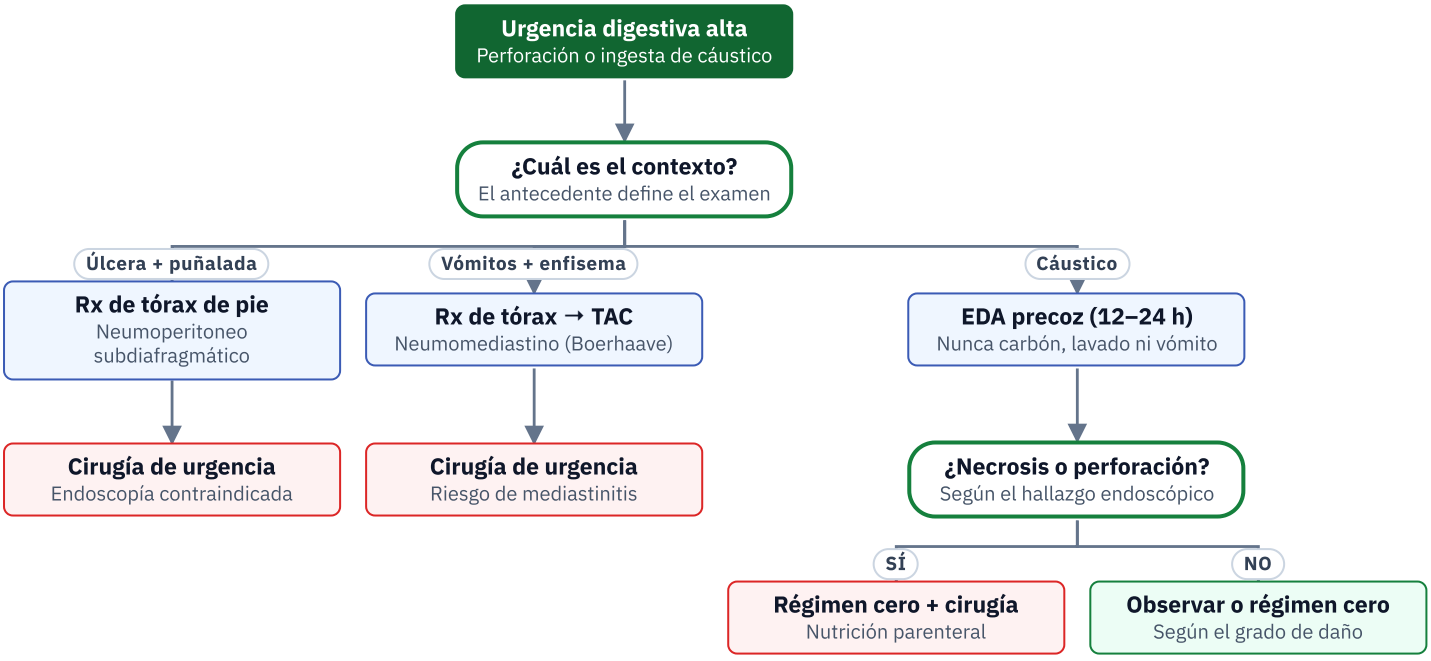


TABLA 1.4 · TRES URGENCIAS DEL TUBO DIGESTIVO ALTO — EXAMEN Y CONTRAINDICACIÓN

CUADRO	EXAMEN INICIAL	TRATAMIENTO	CONTRAINDICADO
Úlcera perforada	Rx tórax de pie (neumoperitoneo)	Cirugía de urgencia	Endoscopía
Perforación esofágica (Boerhaave)	Rx tórax → TAC tórax (neumomediastino)	Cirugía de urgencia	Endoscopía
Ingesta de cáustico	Endoscopía precoz (grada el daño)	Según hallazgo endoscópico	Carbón activado · lavado gástrico · vómito
Mallory-Weiss	Endoscopía digestiva alta	Suele ceder solo; hemostasia endoscópica si sangra	—

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CUADRO	EXAMEN INICIAL	CONDUCTA · CONTRAINDICADO
Perforación sospechada y se necesita contraste	TAC con contraste o medio hidrosoluble	NO bario · NO enema baritada

REGLA DE ORO — **Úlcera perforada** — Rx tórax de pie → cirugía urgente

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **15–16** (pág. 9) · solucionario págs. 21–22.

Clase 1.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

1.5 Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico

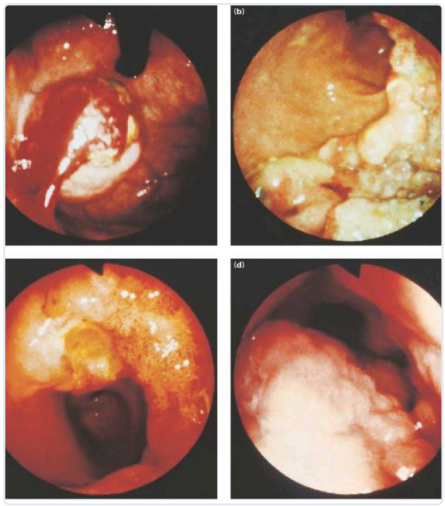
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.004
4.01.1.008 Cáncer gástrico — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Cáncer del esofágo · Epidemiología de los cánceres digestivos · Tumores gástricos benignos · Epidemiología del cáncer.

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Cáncer gástrico**: primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile; causa principal H. pylori.
- Toda epigastralgia **≥ 40 años** o con signo de alarma exige endoscopía digestiva alta con biopsias (GES).
- **Síndrome pilórico (vómitos de retención en aumento) en adulto** = cáncer gástrico hasta demostrar lo contrario.
- El factor pronóstico principal de los cánceres digestivos es la invasión transmural, no las adenopatías.
- **Cáncer de esófago**: escamoso (tabaco/alcohol) vs adenocarcinoma (ERGE/Barrett); radioterapia con rol importante.
- Baja de peso + epigastralgia + ictericia cambia la sospecha a cáncer de páncreas → pedir TAC, no endoscopía.



BORRMANN I A IV
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 63.29

ALGORITMO · CÁNCER DIGESTIVO ALTO: DEL SÍNTOMA AL EXAMEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

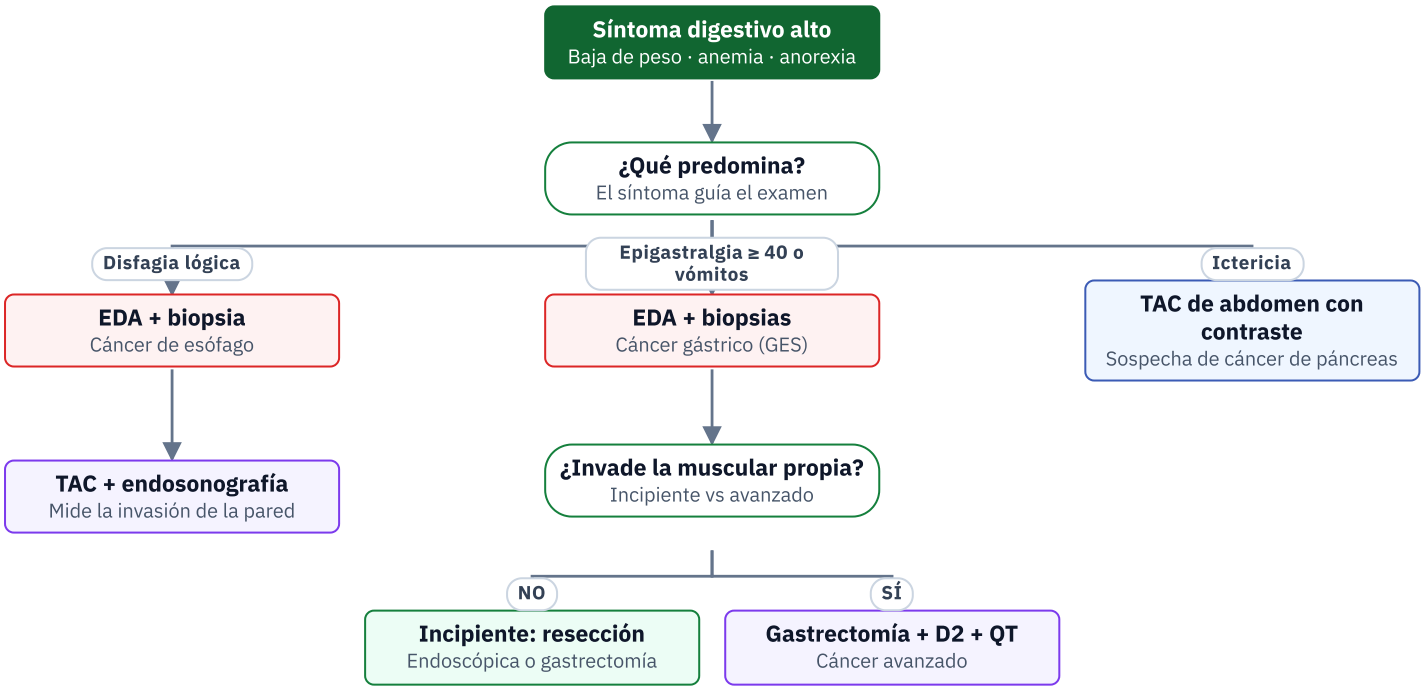


TABLA 1.5 · PRESENTACIONES QUE OBLIGAN A ENDOSCOPÍA DIGESTIVA ALTA

PRESENTACIÓN	SOSPECHA	CONDUCTA
Epigastralgia ≥ 40 años o con signo de alarma	Úlcera o cáncer gástrico	Endoscopía digestiva alta con biopsias
Vómitos posprandiales de retención, en aumento	Cáncer gástrico con síndrome pilórico	Endoscopía digestiva alta
Baja de peso + epigastralgia	Cáncer gástrico	Endoscopía digestiva alta
Baja de peso + epigastralgia + ictericia	Cáncer de páncreas	TAC de abdomen con contraste
Disfagia lógica progresiva + baja de peso	Cáncer de esófago	Endoscopía digestiva alta con biopsia

REGLA DE ORO **Epigastralgia ≥ 40 años: endoscopía** — Con biopsias, garantía GES

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **2, 17–18** (págs. 8, 10) · solucionario págs. 20, 22.

Clase 1.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

1.6 Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

Rentabilidad baja · aparece como alternativa a descartar o hallazgo incidental, casi nunca como diagnóstico principal

4.01.1.006 **Hernia hiatal** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hernias diafragmáticas traumáticas y congénitas · Síndromes mediastínicos

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Hernia hiatal tipo I (deslizamiento, > 95 %)**: casi normal; se observa y solo se trata el reflujo si existe.
- **Hernia hiatal paraesofágica (< 5 %)**: cirugía electiva por riesgo de vólvulo y estrangulación.
- **Hernia diafragmática traumática**: aguda → cirugía urgente; crónica (hallazgo) → cirugía electiva. Nunca se observa.
- **Tumores del mediastino anterior**: 4 T = Timoma, Terrible linfoma, Teratoma, Tiroides.
- Toda masa mediastínica se estudia con TAC de tórax con contraste. Timoma + miastenia gravis → timectomía.



HERNIA PARAESOFÁGICA
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 35

ALGORITMO · HIATO, DIAFRAGMA Y MEDIASTINO: ¿OBSERVAR U OPERAR?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 1.6 · QUÉ SE OBSERVA Y QUÉ SE OPERA

HALLAZGO	CONDUCTA
Hernia hiatal tipo I asintomática	Observar; tratar el reflujo solo si hay síntomas
Hernia hiatal paraesofágica (tipo II–IV)	Cirugía electiva (riesgo de vólvulo/estrangulación)
Hernia diafragmática traumática aguda	Cirugía de urgencia
Hernia diafragmática traumática crónica (hallazgo)	Cirugía electiva
Masa en mediastino (cualquier compartimento)	TAC de tórax con contraste
Timoma con miastenia gravis	Timectomía

REGLA DE ORO **Tipo I: observar** — Paraesofágica: cirugía electiva

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Gastroenterología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 1.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INTESTINO Y COLON

2.1 Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

Rentabilidad media · aparece como diagnóstico diferencial de dolor abdominal crónico y como pregunta de signos de alarma

1.06.1.008 **Trastornos digestivos funcionales** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- El diagnóstico de SII es clínico y positivo (criterios de Roma IV), no de descarte: no se necesita endoscopía si no hay signos de alarma.
- **Signos de alarma (ABCDEFH)**: anemia, baja de peso, cambio del hábito, disfagia, edad > 50 a, familiar con cáncer, hemorragia y síntomas nocturnos.
- Cualquier signo de alarma obliga a estudio con endoscopía o colonoscopía para descartar cáncer.
- **Tratamiento**: educación + manejo del estrés + dieta baja en FODMAP; amitriptilina si predomina la diarrea, polietilenglicol si predomina la constipación.

ALGORITMO · SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE: DIAGNÓSTICO POSITIVO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

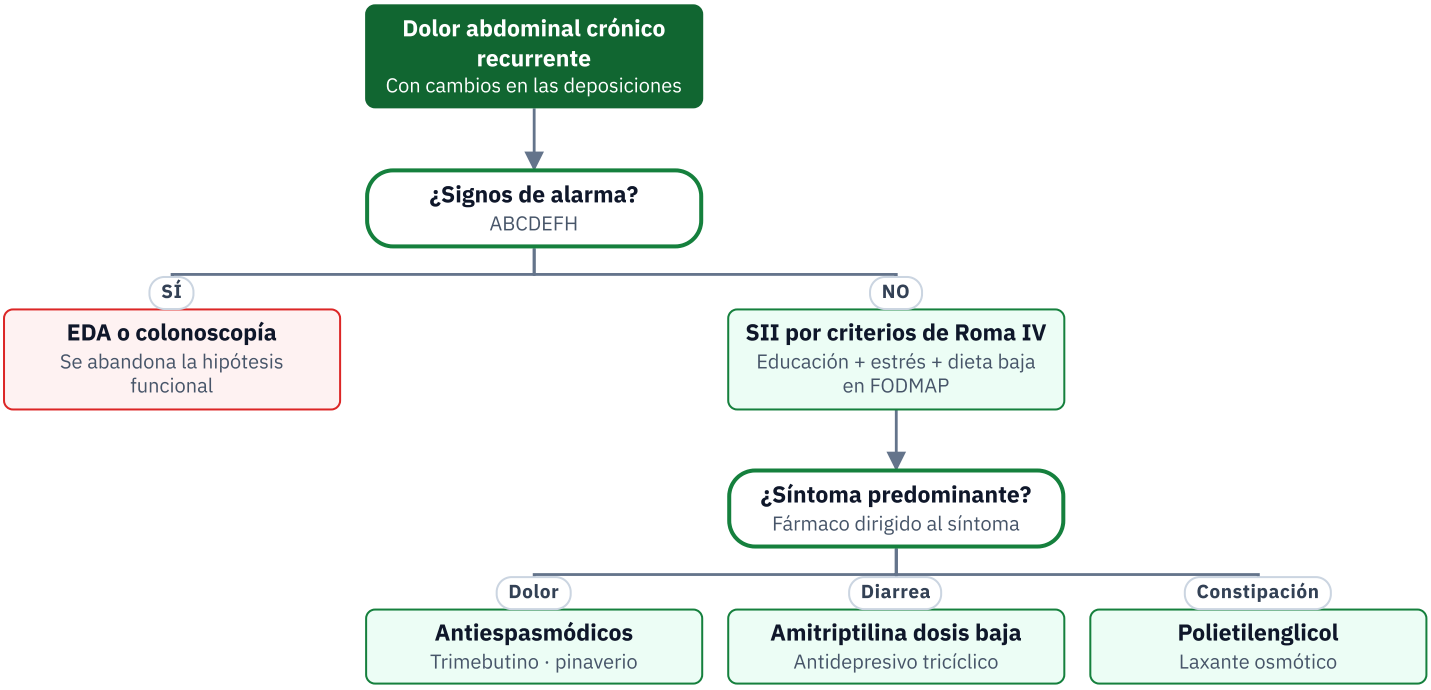


TABLA 2.1 · FUNCIONAL VS ORGÁNICO — CÓMO SE DISTINGUE EN LA PRÁCTICA

RASGO	TRASTORNO FUNCIONAL (SII)	ENFERMEDAD ORGÁNICA
Edad de inicio	Joven (< 50 años)	> 50 años
Síntomas nocturnos	Ausentes (no despiertan)	Presentes
Baja de peso / anemia	Ausentes	Presentes
Relación con la defecación	Característica (alivia o cambia)	Sin relación clara
Exámenes de rutina	Normales	Alterados (VHS, PCR, calprotectina, Hb)

REGLA DE ORO **Roma IV sin alarma = SII** — No se necesita endoscopía

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **19, 29–30** (págs. 10–12) · solucionario págs. 22–23.

Clase 2.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INTESTINO Y COLON

2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación

Rentabilidad media-alta · plan de hidratación y cuándo (no) dar antibióticos o antidiarreicos

★★★ PRIORIDAD ALTA
20 preguntas reales 2013–2025

1.06.2.005 **Diarrea aguda** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Diarrea crónica · Constipación · Diarrea asociada a antibióticos · Parasitosis intestinales · Determinación toxina C difficile en deposiciones · Constipación y fecalomas

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Regla de los 3**: diarrea = > **3 deposiciones**/día; constipación = < **3 deposiciones**/semana.
- **Diarrea aguda**: el manejo es la hidratación (Plan A/B/C). Los antidiarreicos están contraindicados.
- Antibiótico en diarrea aguda solo si disentería, diarrea del viajero, fiebre persistente o sepsis. Elección: ciprofloxacino.
- **Diarrea post-antibióticos (último mes)** → C. difficile: PCR de toxina; la respuesta se evalúa clínicamente, no con PCR de control.
- Diarrea crónica o constipación con signos de alarma en adulto mayor → colonoscopía para descartar cáncer.



C. DIFFICILE EN COLONOSCOPÍA
Atlas EUNACOM 2026

ALGORITMO · DIARREA DEL ADULTO: EL TIEMPO DEFINE EL ESTUDIO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

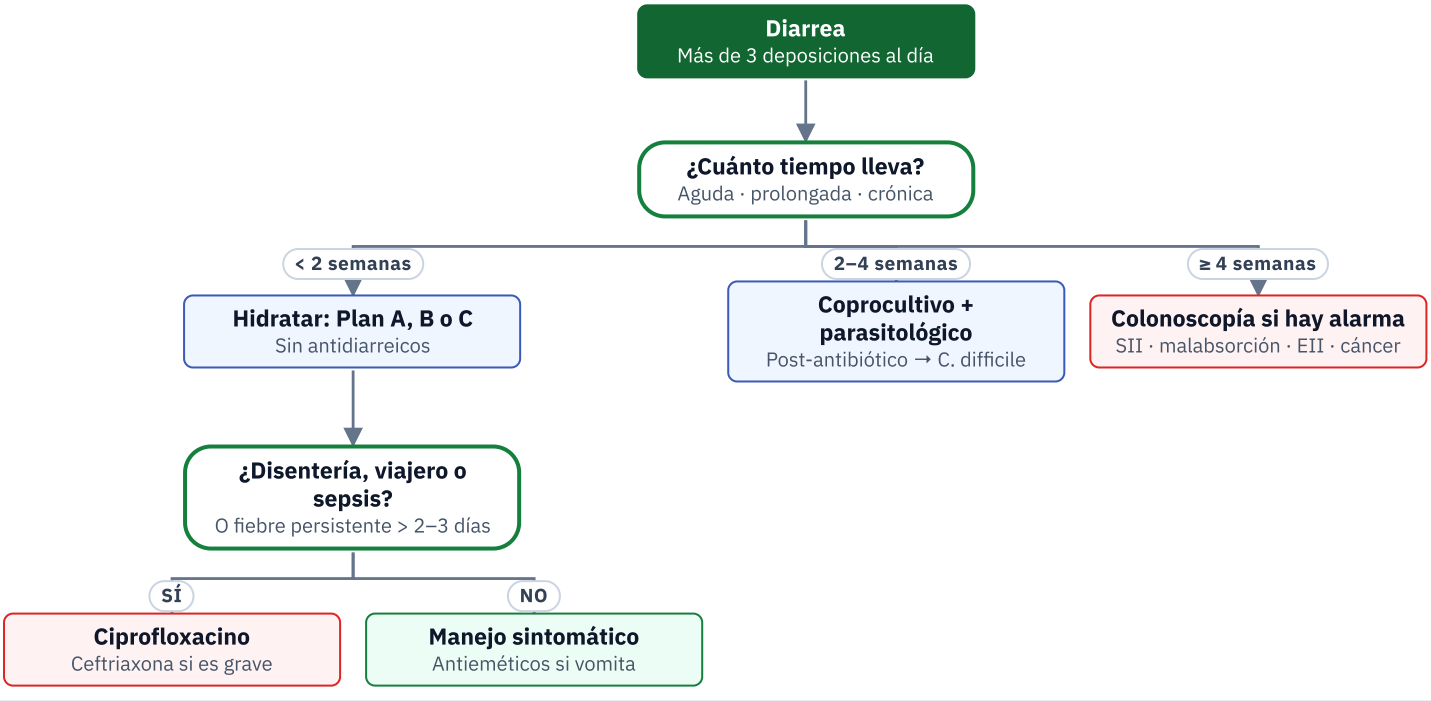


TABLA 2.2 · DIARREA AGUDA — PLAN DE HIDRATACIÓN

PLAN	ESTADO DEL PACIENTE	CONDUCTA
A	Sin deshidratación (< 5 % pérdida de peso)	SRO 100–200 mL post deposición, en casa
B	Deshidratación moderada (5–10 %): irritable, mucosas secas, ojos hundidos	SRO 50–100 mL/kg en 4–6 h y reevaluar
C	Deshidratación grave (> 10 %), shock, compromiso de conciencia, íleo, vómitos incoercibles	Cristaloides endovenosos

REGLA DE ORO — **Plan A, B o C** — Según el grado de deshidratación

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **3, 20, 28, 31–32, 64, 73** (págs. 8, 10–12, 16–17) · solucionario págs. 20, 22–24, 28–29.

Clase 2.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INTESTINO Y COLON

2.3 Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.015 Enfermedad celiaca — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Síndrome de malabsorción · Intolerancia a la lactosa · Laboratorio inicial de síndrome de malabsorción · Síndrome malabsorción · Manejo dietético en enfermos digestivos

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Test de Sudán confirma esteatorrea; test de D-xilosa localiza**: alterado = pared (celíaca/Crohn), normal = enzimas (páncreas).
- Anemia ferropénica refractaria al hierro oral, con o sin diarrea, obliga a descartar enfermedad celíaca.
- **Diagnóstico de celíaca**: anti-transglutaminasa IgA + IgA total, y biopsia duodenal (con el paciente consumiendo gluten).
- **Celíaca que no responde**: casi siempre transgresión dietética; si cumple y anticuerpos negativos, sospechar linfoma MALT.
- **Galactosemia (RN con cataratas e ictericia)**: fórmula de soya; lactancia materna y "leche sin lactosa" están contraindicadas.



DERMATITIS HERPETIFORME
Harrison 21.ª ed., p. 413

ALGORITMO · MALABSORCIÓN: DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

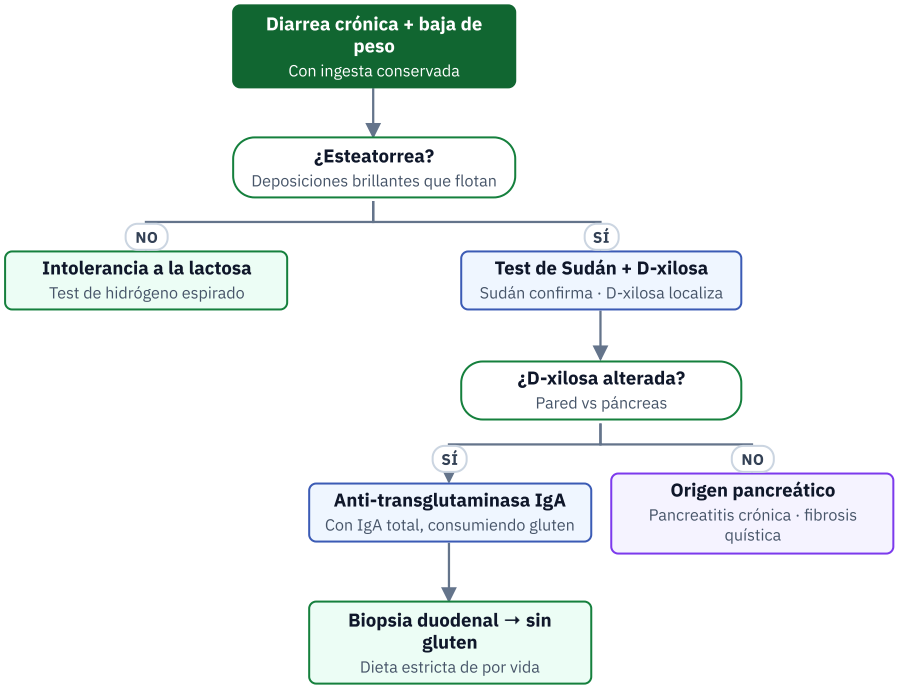


TABLA 2.3 · MALABSORCIÓN — INTERPRETAR LA D-XILOSA; LACTOSA VS GALACTOSA

PRUEBA / CUADRO	HALLAZGO	SIGNIFICADO
D-xilosa alterada	Baja excreción urinaria	Problema parietal: celíaca, Crohn, intestino corto
D-xilosa normal	Excreción urinaria normal	Problema enzimático: pancreatitis crónica, fibrosis quística
Anticuerpos celíacos negativos con clínica sugerente	Verificar IgA total	Déficit de IgA da falsos negativos
Intolerancia a la lactosa	Diarrea osmótica sin esteatorrea, en el adulto	Reducir lactosa; leche sin lactosa útil
Galactosemia	Recién nacido con cataratas, ictericia, retraso	Fórmula de soya; lactancia y leche sin lactosa prohibidas

REGLA DE ORO **Sudán confirma, D-xilosa localiza** — Alterada: pared · normal: páncreas

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **21, 24, 26, 33–34** (págs. 10–12) · solucionario págs. 22–24.

Clase 2.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INTESTINO Y COLON

2.4 Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn

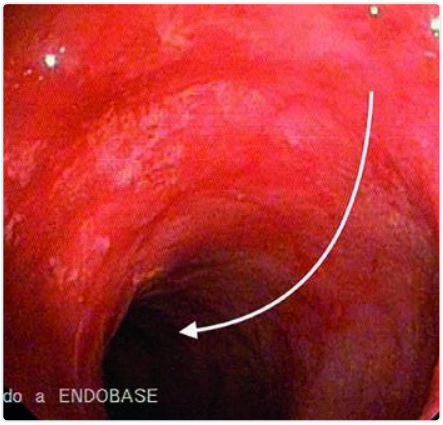
★★★ PRIORIDAD ALTA
22 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.018 **Enfermedad inflamatoria intestinal** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Endoscopía digestiva alta y baja · Ileostomías

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Joven con diarrea disentérica crónica + fiebre + baja de peso** → colonoscopía con biopsias.
- **Colitis ulcerosa**: solo colon, desde el recto, continua, mucosa, p-ANCA. Crohn: boca-ano, en parches, transmural, ASCA.
- Basta UNA característica de Crohn (íleon, fístula, parches, masa, perianal) para diagnosticarlo.
- **Colitis ulcerosa**: riesgo de megacolon tóxico y de cáncer colorrectal tras **8–10 años** (vigilancia colonoscópica).
- **Cirugía**: colectomía cura la colitis ulcerosa; en Crohn solo se reseca el segmento complicado y nunca cura.



COLITIS ULCEROSA
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 103

ALGORITMO · ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: ¿CU O CROHN?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

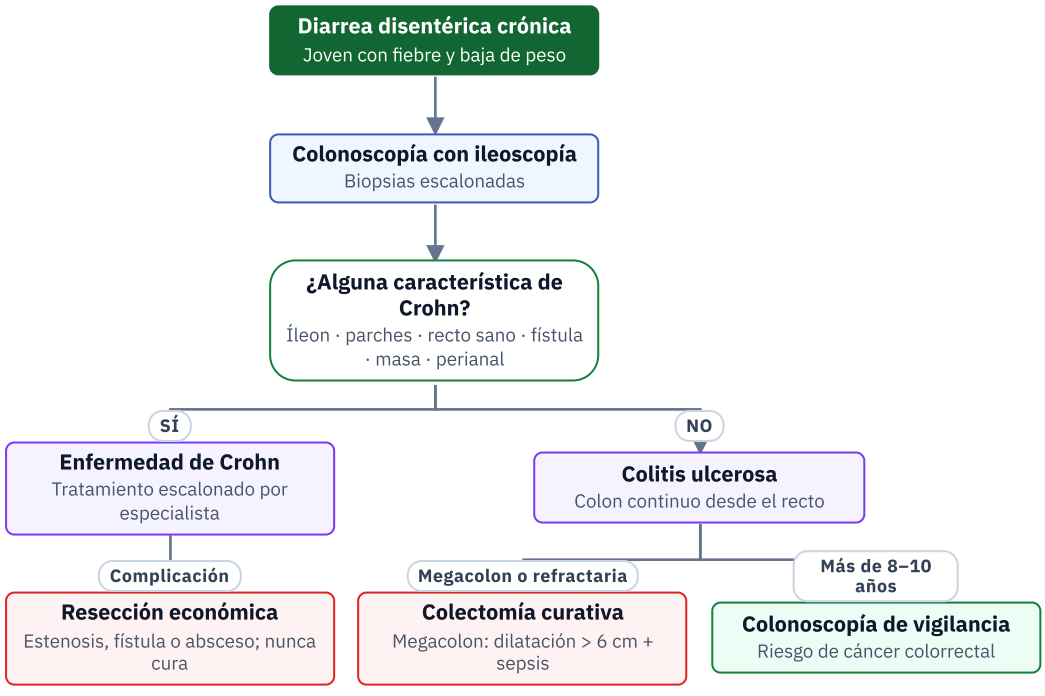


TABLA 2.4 · COLITIS ULCEROSA VS ENFERMEDAD DE CROHN

RASGO	COLITIS ULCEROSA	ENFERMEDAD DE CROHN
Localización	Solo colon, desde el recto	Boca a ano (típico íleon distal)
Distribución	Continua	En parches (skip lesions)
Profundidad	Mucosa	Transmural
Anticuerpos	p-ANCA	ASCA
Complicaciones	Megacolon tóxico, cáncer colorrectal	Fístulas, abscesos, obstrucción
Cirugía	Colectomía = curativa	Resección segmentaria; nunca curativa

REGLA DE ORO **Joven + disentería + baja de peso** — Colonoscopía con ileoscopía y biopsias

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **23, 35–36** (págs. 11–12) · solucionario págs. 23–24.

Clase 2.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INTESTINO Y COLON

2.5 Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje

Alta rentabilidad · escenario clásico (adulto mayor + constipación + anemia) y tamizaje poblacional

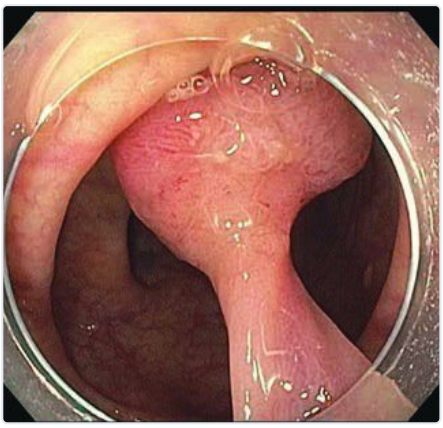
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
11 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.029 Tumores de colon — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Pólipos de colon y recto · Cáncer colorectal · Métodos de tamizaje para cáncer de colon y hepatocarcinoma · Colonoscopía · Sangre oculta en deposiciones

LO QUE TE PREGUNTAN

- La mayoría de los cánceres de colon nacen de un adenoma; resecar adenomas en la colonoscopía previene el cáncer.
- **Constipación reciente + anemia ferropénica en el adulto mayor** = cáncer de colon → colonoscopía.
- **Innumerables pólipos** = poliposis adenomatosa familiar → colectomía total profiláctica (**100 %** maligniza).
- El CEA solo sirve para el seguimiento posoperatorio, no para el diagnóstico ni el pronóstico.
- El test de sangre oculta es tamizaje de asintomáticos; al paciente con signos de alarma se le hace colonoscopía.



PÓLIPO PEDICULADO
Harrison 21.ª ed., p. 2433

ALGORITMO · CÁNCER COLORRECTAL: ¿TAMIZAJE O COLONOSCOPÍA?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

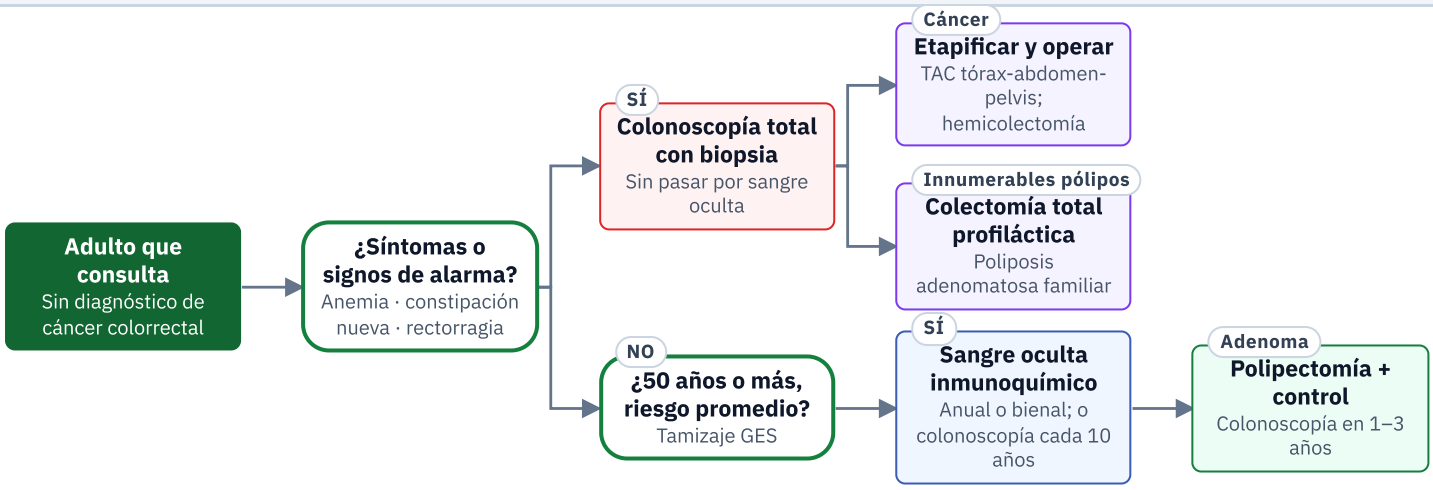


TABLA 2.5 · PÓLIPOS Y SÍNDROMES HEREDITARIOS DE CÁNCER DE COLON

HALLAZGO	RIESGO	CONDUCTA
Pólipo hiperplásico	Nulo	Observar
Pólipo adenomatoso (tubular/velloso)	Premaligno	Polipectomía + colonoscopía de control 1–3 años
Poliposis adenomatosa familiar (PAF)	100 % evoluciona a cáncer	Colectomía total profiláctica
Síndrome de Lynch (HNPCC)	Alto, pocos pólipos	Vigilancia colonoscópica intensiva
Paciente sintomático con signos de alarma	A descartar cáncer	Colonoscopía (no test de sangre oculta)

REGLA DE ORO **Adenoma: polipectomía y control** — Hiperplásico: observar

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, pregunta **27** (pág. 11) · solucionario pág. 23.

Clase 2.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INTESTINO Y COLON

2.6 Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula

PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

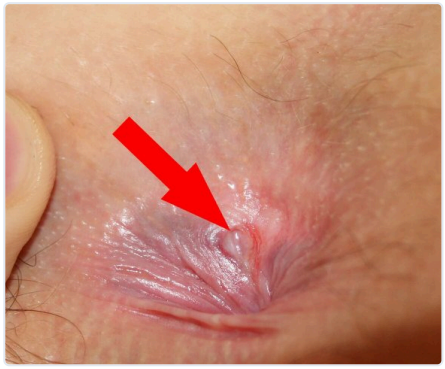
Rentabilidad media · distinguir manejo médico de quirúrgico por el patrón de dolor

4.01.1.016 **Hemorroides - fisura anal** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Abscesos y fístulas ano rectales · Fisura anorectal

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Fisura ≠ fístula**: la fisura es una herida dolorosa de manejo médico; la fístula es un trayecto de manejo quirúrgico.
- **Hemorroide interno** = sangrado sin dolor; siempre descartar otras causas de hemorragia digestiva baja.
- **Hemorroide externo trombosado**: baños de asiento; trombectomía útil solo dentro de las primeras **48–72 h**.
- **Absceso perianal**: drenaje quirúrgico en pabellón. Los antibióticos solos no bastan.
- En la esfinterotomía de la fisura crónica se secciona el esfínter interno; nunca el externo (incontinencia).



FISURA ANAL
Wikimedia Commons «Anal fissure 1.jpg», Public domain, Bernardo Gui

ALGORITMO · DOLOR Y SANGRADO ANAL: ¿MÉDICO O PABELLÓN?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

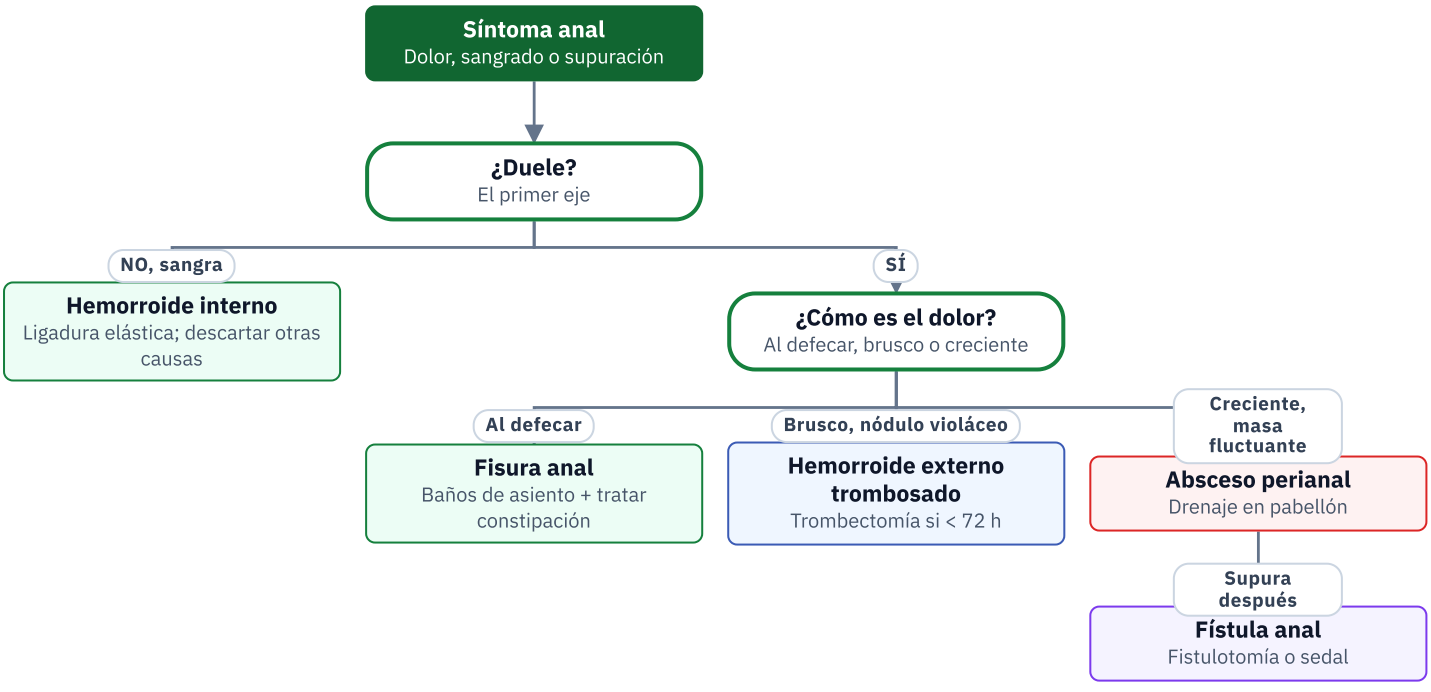


TABLA 2.6 · PATOLOGÍA PERIANAL — CLÍNICA Y CONDUCTA

CUADRO	CLAVE CLÍNICA	CONDUCTA
Fisura anal	Dolor con la defecación + rectorragia al papel	Baños de asiento + tratar constipación
Hemorroide interno	Hematoquecia sin dolor	Ligadura elástica electiva; descartar otras causas
Hemorroide externo trombosado	Dolor agudo + nódulo violáceo	Baños de asiento; trombectomía si < 72 h
Absceso perianal	Dolor creciente + masa fluctuante	Drenaje en pabellón (no ATB solos)
Fístula anal	Orificio cutáneo que supura crónicamente	Cirugía (fistulotomía)
Absceso pelvirrectal	Absceso + sepsis + síntomas urinarios	RM de pelvis + drenaje + ATB endovenosos

REGLA DE ORO **Fisura: baños de asiento** — Esfinterotomía: interno, nunca externo

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Gastroenterología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 2.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HÍGADO

3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico

★★★ PRIORIDAD ALTA
20 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.007 **Colestasia** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Ictericia obstructiva · Cáncer de páncreas · Ecotomografía abdominal · Cáncer de páncreas y otros tumores preampulares · Hemograma, perfil bioquímico, pefil hepático. · Perfil bioquímico · Estudio de perfil hepático

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Paso 1**: ¿bilirrubina indirecta (Gilbert, hemólisis) o directa? Paso 2 en la directa: transaminasas (hepatitis) vs FA/GGT (colestasia).
- **Síndrome de Gilbert**: hiperbilirrubinemia indirecta con el resto de las pruebas hepáticas normales → observar.
- **Colestasia con dolor** = patología biliar; con dolor y fiebre = colangitis; sin dolor en el adulto mayor = cáncer.
- **Cáncer de páncreas**: 3 D (diabetes, depresión, dolor) + baja de peso + ictericia silente + Courvoisier-Terrier.
- La ecografía abdominal es siempre el primer examen de toda ictericia; el TAC se reserva para la sospecha de cáncer de páncreas.



ICTERICIA ESCLERAL
Knoop, Atlas of Emergency Medicine, p. 34

ALGORITMO · ICTERICIA: DOS PREGUNTAS DE LABORATORIO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

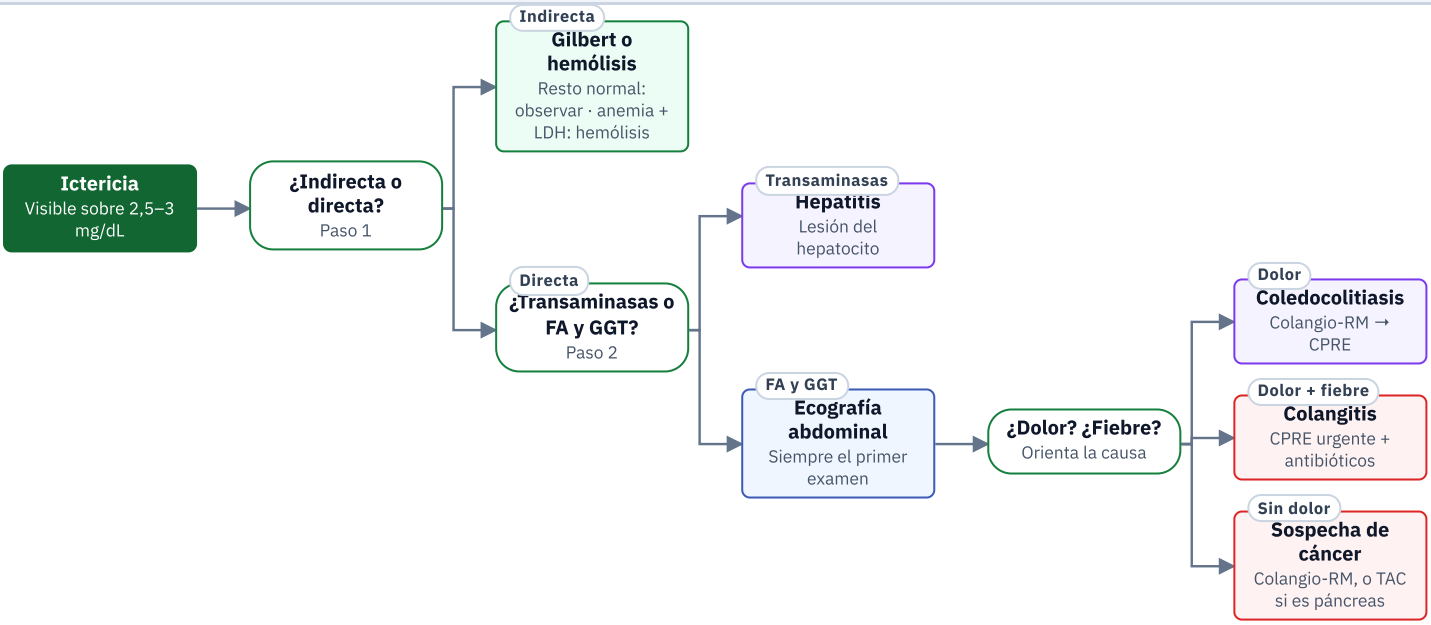


TABLA 3.1 · ICTERICIA — PATRÓN BIOQUÍMICO Y ORIENTACIÓN

PATRÓN	CONTEXTO	DIAGNÓSTICO / CONDUCTA
Bilirrubina indirecta aislada, resto normal	Joven asintomático	Síndrome de Gilbert → observar
Bilirrubina indirecta + anemia + LDH alta	Esquistocitos	Hemólisis → tratar la causa
↑ AST/ALT (transaminasas)	Con o sin ictericia	Hepatitis
↑ FA/GGT + dolor	Cólico biliar	Coledocolitiasis → eco → colangio-RM → CPRE
↑ FA/GGT + dolor + fiebre	Tríada de Charcot	Colangitis → CPRE urgente + antibióticos
↑ FA/GGT sin dolor	Adulto mayor, baja de peso	Cáncer → eco → colangio-RM (o TAC si páncreas)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PATRÓN	CONTEXTO	DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA
Ictericia fluctuante con anemia o melena	Ampuloma	Duodenoscopía o ecoendoscopía con biopsia · Whipple

REGLA DE ORO — **Paso 1: indirecta o directa** — Indirecta aislada = Gilbert

PRACTICA — **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **1, 38, 49–50** (págs. 8, 13, 15) · solucionario págs. 20, 25–26.

Clase 3.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HÍGADO

3.2 Hepatitis Aguda y Crónica

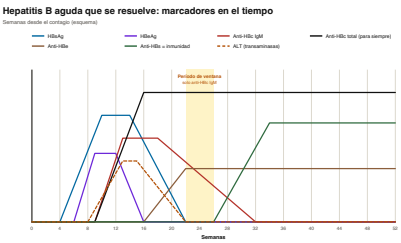
★★☆
PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.019 Hepatitis aguda A no complicada — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Hepatitis agudas B, C, por otros virus, por drogas y tóxicas · Hepatitis crónica · Estudio de marcadores virales para hepatitis A, B y C · Hepatitis viral · Insuficiencia hepática aguda · Ecotomografia abdominal · Estudio funcional hepático · Hepatitis aguda A complicada · Esteatopatía no alcohólica · Biopsia hepática

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Hepatitis aguda**: el riesgo es la fulminante (ictericia + encefalopatía); se vigila con el tiempo de protrombina.
- **Hepatitis crónica**: el riesgo es la cirrosis; se evalúa con biopsia o elastografía.
- **HBsAg** = "hay virus"; IgM anti-HBc = "es aguda"; HBsAg (+) con IgM anti-HBc (–) = hepatitis B crónica.
- **Hepatitis A**: contacto extradomiciliario → vacuna; contacto intradomiciliario → inmunoglobulina.
- **Relación AST/ALT > 2** = hepatitis alcohólica. Paracetamol → N-acetilcisteína.
- **Prurito + AMA + mujer** = cirrosis biliar primaria. Colitis ulcerosa + ANCA + vía biliar "en rosario" = colangitis esclerosante primaria.



MARCADORES EN EL TIEMPO
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · HEPATITIS: AGUDA VS CRÓNICA

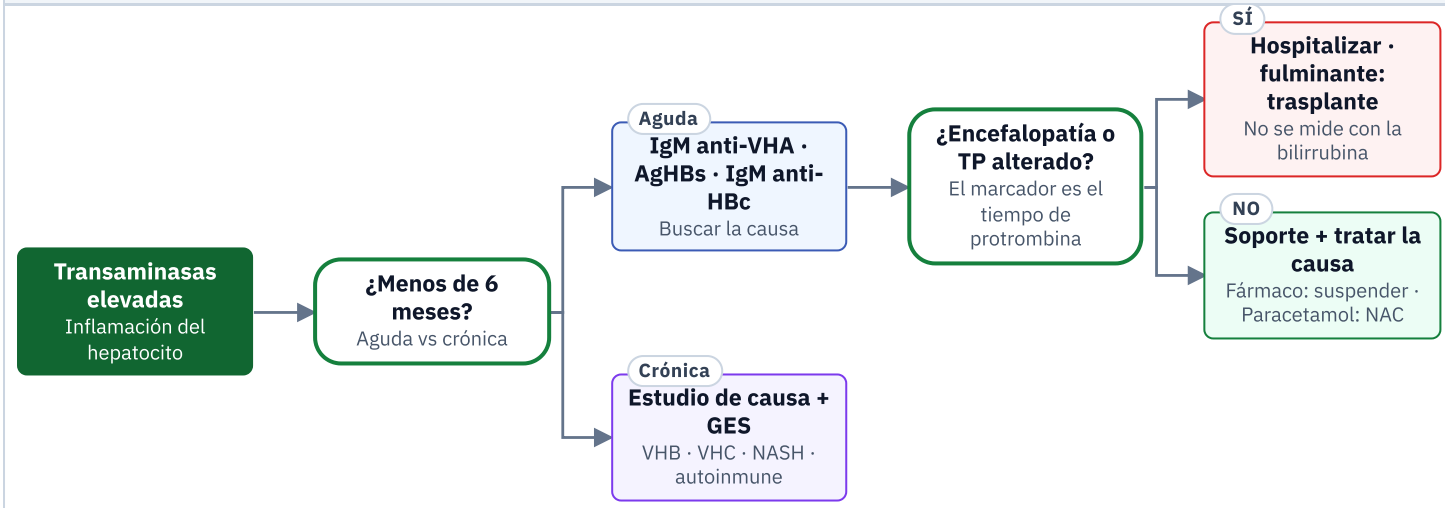


TABLA 3.2 · SEROLOGÍA DE LA HEPATITIS B — LAS COMBINACIONES QUE SE PREGUNTAN

AGHBS	IGM ANTI-HBC	ANTI-HBS	INTERPRETACIÓN
(+)	(+)	(–)	Hepatitis B aguda
(+)	(–)	(–)	Hepatitis B crónica
(–)	(+)	(–)	Período de ventana (aguda, antígeno aún negativo)
(–)	(–)	(+) con anti-HBc IgG (+)	Infección pasada resuelta
(–)	(–)	(+) con anti-HBc (–)	Inmune por vacuna

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

MARCADORES	INTERPRETACIÓN	TRAMPA
AgHBs – · IgM anti-HBc +	Período de ventana	Sigue siendo aguda

REGLA DE ORO **Aguda: fulminante · vigilar TP** — No la bilirrubina ni las transaminasas

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **39–41, 45–46, 51–53** (págs. 13–15) · solucionario págs. 25–27.

Clase 3.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HÍGADO

3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
11 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.005 **Cirrosis hepática** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Ascitis · Peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico · Encefalopatía hepática · Conceptos generales de hipertensión portal · Paracentesis · Regímenes dietéticos fundamentales · Insuficiencia hepática crónica · Estudio de función hepática · Encefalopatías tóxico metabólicas (urémica, hepática, etc)

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Todo cirrótico con ascitis que consulta**: paracentesis diagnóstica antes que nada (descartar PBE).
- **PBE: ≥ 250 PMN/mm³** → cefotaxima/ceftriaxona endovenosa + albúmina (días 1 y 3).
- **Várices**: profilaxis primaria = propranolol; secundaria = propranolol + ligadura; sangrado activo = terlipresina + antibióticos + ligadura.
- **Ascitis a tensión**: paracentesis evacuadora + albúmina (**~8 g/L**). El gradiente albúmina suero-ascitis **≥ 1,1 confirma** hipertensión portal.
- **Encefalopatía**: tratar el precipitante (casi siempre infección) + lactulosa a **2–3 deposiciones**/día. El TIPS está contraindicado.
- **Síndrome hepatorrenal**: terlipresina + albúmina y trasplante; pronóstico muy malo.



ECOGRAFÍA EN LA CIRROSIS
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 42

ALGORITMO · COMPLICACIONES DEL CIRRÓTICO: ¿QUÉ HAGO PRIMERO?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

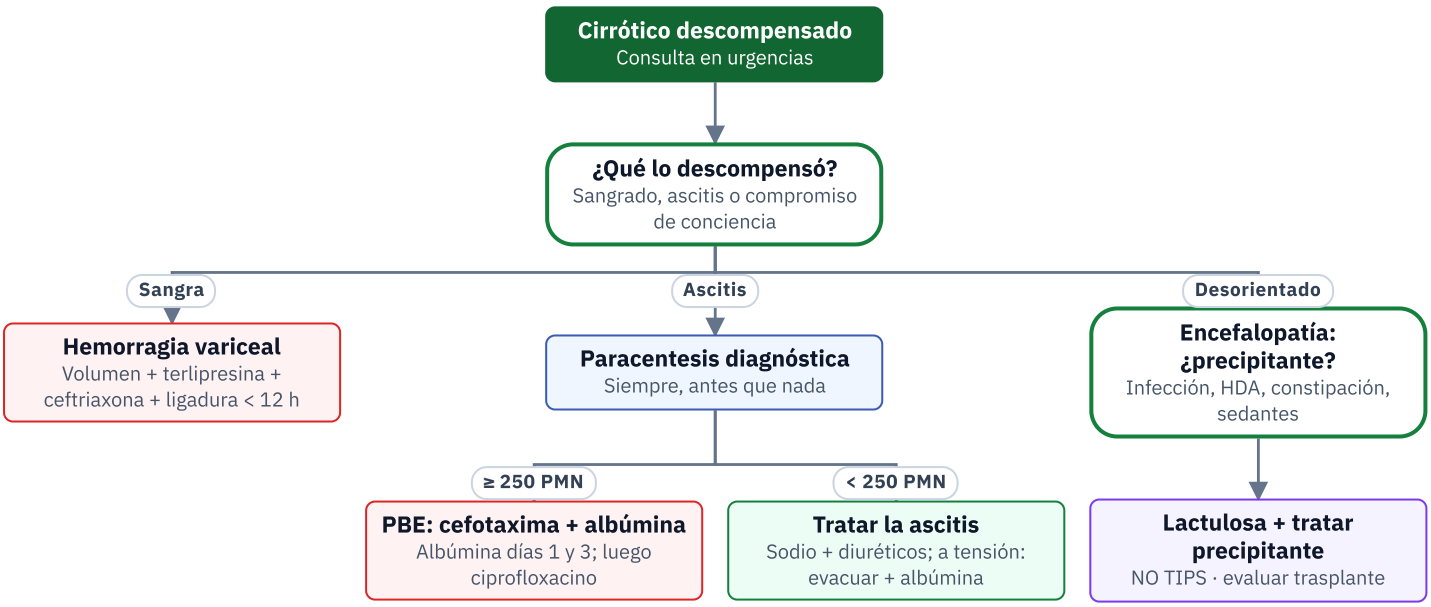


TABLA 3.3 · COMPLICACIONES DEL CIRRÓTICO — CONDUCTA CLAVE

SITUACIÓN	CONDUCTA DE PRIMERA LÍNEA	TRAMPA FRECUENTE
Várices que nunca sangraron	Betabloqueo no selectivo (propranolol)	Ligar de entrada sin indicación
Hemorragia variceal activa	Volumen + terlipresina + antibióticos + ligadura	Omitir los antibióticos
Ascitis a tensión	Paracentesis diagnóstica primero, luego evacuadora + albúmina	Drenar sin descartar PBE
Líquido ascítico con ≥ 250 PMN/mm³	Cefotaxima + albúmina	Usar aminoglucósidos (nefrotóxicos)
Encefalopatía + ascitis refractaria	Lactulosa + tratar precipitante; NO TIPS	Indicar TIPS

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

SITUACIÓN	PRIMERA LÍNEA	TRAMPA FRECUENTE
Dieta del cirrótico	Sodio menor de 2 g al día; sin restringir proteínas	Restringir proteínas en la encefalopatía

REGLA DE ORO — **Cirrótico con ascitis: paracentesis diagnóstica** — Antes que nada

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **37, 42, 44, 47–48, 54** (págs. 13–15) · solucionario págs. 24–27.

Clase 3.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · HÍGADO

3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares

Rentabilidad media · el aspecto ecográfico y el contexto clínico resuelven casi toda la clase

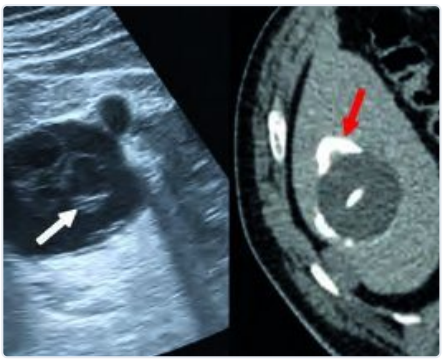
★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
13 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.024 **Masa hepática** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Quistes y abscesos hepáticos · Hidatidosis hepática · Cáncer de vesícula y vías biliares · Tumores hepáticos · Biopsia hepática

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Anecogénica lisa** = quiste simple (observar); hiperecogénica homogénea = hemangioma (observar).
- **Hipoecogénica única y homogénea + anticonceptivos orales** = adenoma → suspender estrógenos y resecar si > **5 cm**.
- **Heterogénea e irregular en un hígado cirrótico + AFP alta** = hepatocarcinoma.
- **Múltiples lesiones hipoecogénicas** = metástasis → buscar el primario.
- **Pólipo vesicular ≥ 10 mm, heterogéneo o con colelitiasis** → colecistectomía; sospecha de cáncer invasor → cirugía abierta.



QUISTE HIDATÍDICO
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 43

ALGORITMO · LESIÓN HEPÁTICA EN LA ECOGRAFÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

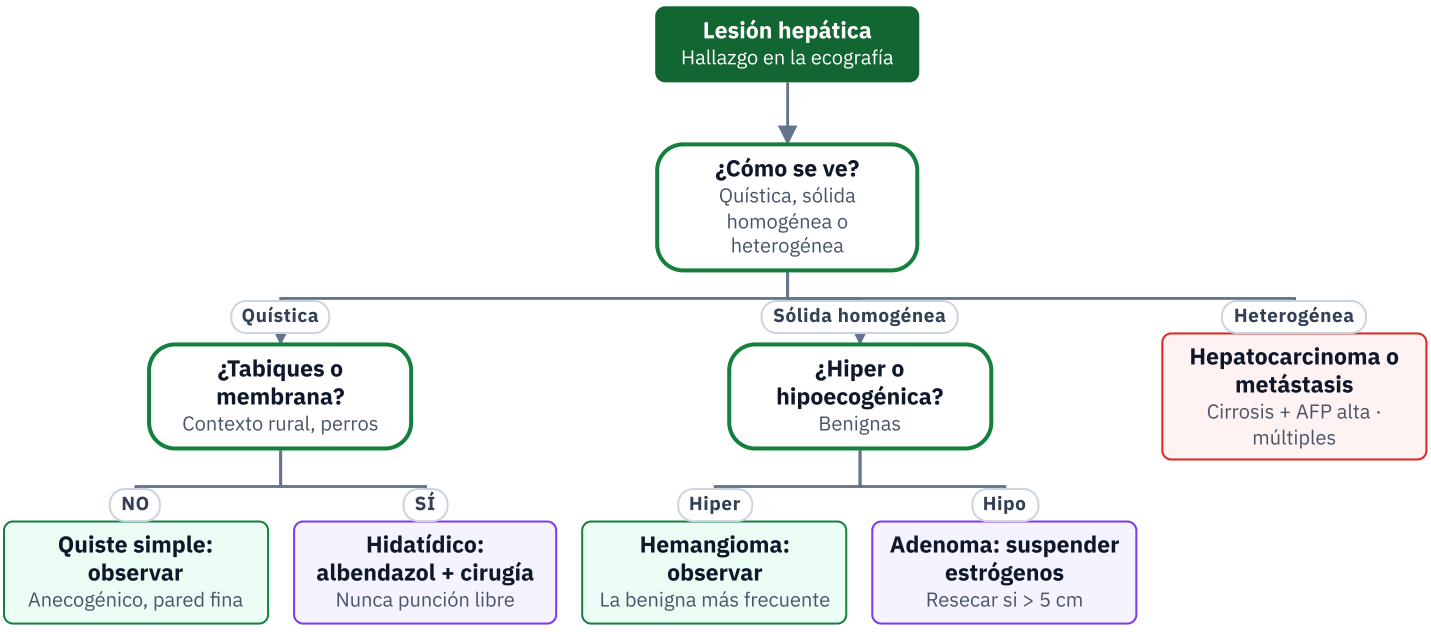


TABLA 3.4 · LESIÓN HEPÁTICA EN LA ECOGRAFÍA — DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA

ASPECTO ECOGRÁFICO	DIAGNÓSTICO PROBABLE	CONDUCTA
Anecogénica, pared fina, sin tabiques	Quiste simple	Observar
Quística con membrana/tabiques (contexto rural)	Quiste hidatídico	Albendazol + cirugía
Hiperecogénica, homogénea	Hemangioma	Observar
Hipoecogénica única y homogénea, mujer con ACO	Adenoma hepático	Suspender estrógenos; resecar si > 5 cm o sintomático
Heterogénea irregular en cirrótico + AFP alta	Hepatocarcinoma	TAC/RM trifásico → resección/ablación/trasplante
Múltiples lesiones hipoecogénicas	Metástasis	Buscar el tumor primario

REGLA DE ORO **Anecogénica lisa = quiste simple** — Hiperecogénica homogénea = hemangioma

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **43, 55–57** (págs. 14–16) · solucionario págs. 25, 27.

Clase 3.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VÍA BILIAR Y PÁNCREAS

4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis

Alta rentabilidad · regla de "sumar síntomas" separa las 4 entidades y define cuál se opera de urgencia

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

1.06.1.006 Colelitiasis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Colecistitis aguda · Colangitis · Colangiografía endoscópica · Colangiografía por resonancia magnética

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Solo dolor** = cólico biliar; + fiebre = colecistitis; + ictericia = coledocolitiasis; + fiebre + ictericia = colangitis (Charcot).
- Toda colelitiasis se opera (colecistectomía laparoscópica electiva), incluso asintomática — riesgo de cáncer de vesícula en Chile.
- La colecistitis aguda es la única patología biliar de resolución quirúrgica urgente (colecistectomía < **72 h**).
- **Coledocolitiasis**: eco → colangiorresonancia → CPRE. Directo a CPRE si hay colangitis o si la eco ve el cálculo.
- **Colangitis**: lo esencial es el drenaje biliar urgente por CPRE, junto con volumen y antibióticos.



COLELITIASIS
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 44

ALGORITMO · PATOLOGÍA BILIAR: QUÉ ACOMPAÑA AL DOLOR

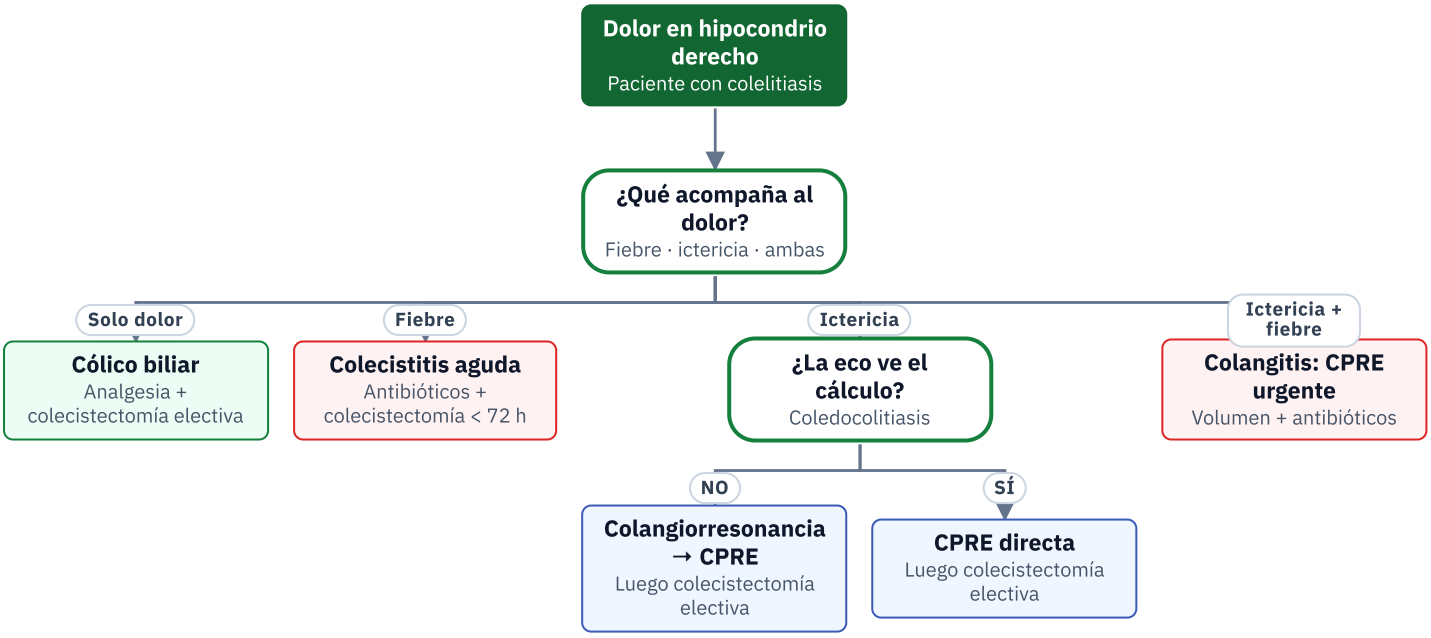


TABLA 4.1 · PATOLOGÍA BILIAR — CLÍNICA, EXAMEN Y CIRUGÍA

CUADRO	DOLOR + ...	CONDUCTA
Cólico biliar (colelitiasis sintomática)	solo dolor	Analgesia; colecistectomía electiva
Colecistitis aguda	dolor + fiebre + Murphy	Antibióticos + colecistectomía de urgencia (< 72 h)
Coledocolitiasis	dolor + ictericia	Eco → colangio-RM → CPRE → colecistectomía electiva
Colangitis aguda	dolor + ictericia + fiebre (Charcot)	Volumen + antibióticos + CPRE urgente
Vesícula en porcelana / escleroatrófica	hallazgo (riesgo de cáncer)	Colecistectomía electiva

REGLA DE ORO **Solo dolor = cólico** — + fiebre = colecistitis

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **58–63, 66–67, 69–70** (págs. 16–17) · solucionario págs. 27–28.

Clase 4.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · VÍA BILIAR Y PÁNCREAS

4.2 Pancreatitis Aguda

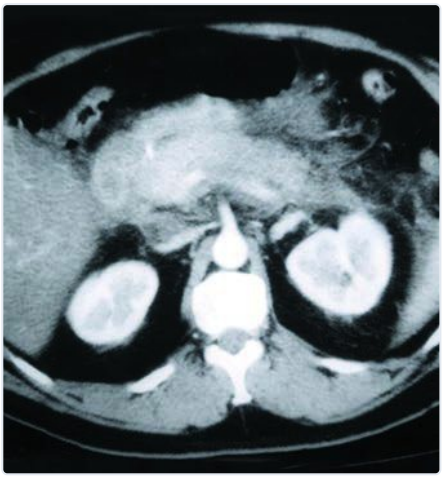
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
9 preguntas reales 2013–2025

1.06.2.010 **Pancreatitis aguda** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: TAC abdominal · Pancreatitis crónica · Pancreatitis aguda · Alimentación en enfermedades digestivas

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Diagnóstico** = 2 de 3: dolor típico + lipasa/amilasa > **3×** el límite superior + imagen compatible. Con los dos primeros no se necesita TAC.
- La magnitud de la elevación enzimática NO se correlaciona con la gravedad; el hematocrito y el BUN en ascenso a las **24 h** sí predicen necrosis.
- **Pilar del tratamiento**: reposición de volumen precoz y agresiva con Ringer lactato, ajustada a diuresis. Es lo que más reduce la mortalidad.
- Realimentación oral precoz (**24–72 h**) apenas cede el dolor, incluso en pancreatitis grave. Se evita la nutrición parenteral.
- NO antibióticos profilácticos en pancreatitis no infectada. CPRE urgente (< **24 h**) solo si hay colangitis asociada.
- **Pancreatitis biliar leve**: colecistectomía en el mismo ingreso para prevenir la recurrencia.



PANCREATITIS EDEMATOSA
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 258

ALGORITMO · PANCREATITIS AGUDA: DIAGNÓSTICO Y PRIMERAS 48 HORAS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

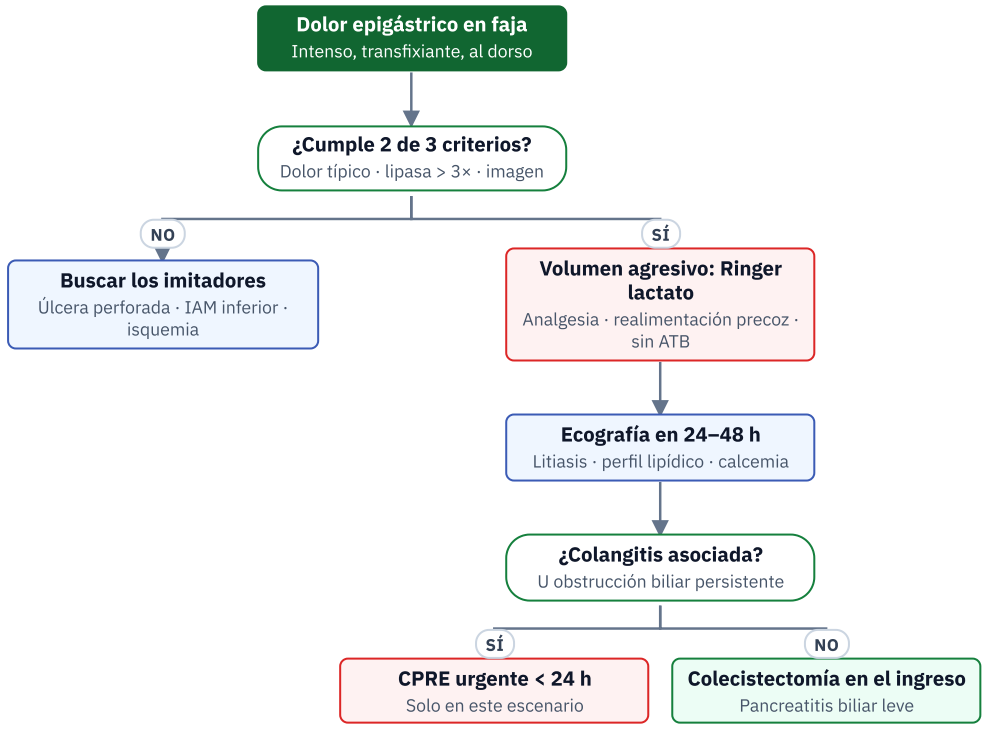


TABLA 4.2 · DOLOR EPIGÁSTRICO AGUDO — CÓMO SE SEPARA LA PANCREATITIS DE SUS IMITADORES

DIAGNÓSTICO	CLAVE QUE LO DISTINGUE	EXAMEN QUE CONFIRMA
Pancreatitis aguda	Dolor transfixiante al dorso + lipasa > 3× · íleo	Lipasa/amilasa; TAC a las 72 h si evoluciona mal
Coledocolitiasis	Dolor + ictericia, sin fiebre · lipasa normal o poco elevada	Ecografía (colédoco > 7 mm) → colangio-RM
Colangitis aguda	Tríada de Charcot: dolor + ictericia + fiebre	Ecografía + hemocultivos → CPRE
Úlcera perforada	Dolor brusco "en puñalada", abdomen en tabla	Radiografía de tórax de pie: neumoperitoneo
IAM de cara inferior	Factores de riesgo CV, síntomas vagales	ECG de 12 derivaciones + troponina
Isquemia mesentérica	Dolor desproporcionado al examen, FA, acidosis con lactato	Angio-TAC de abdomen

REGLA DE ORO **Dolor + lipasa > 3×: basta** — Sin TAC; TAC a las 72 h si evoluciona mal

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **65, 68, 71–72** (págs. 16–17) · solucionario págs. 28–29.

Clase 4.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS

5.1 Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis

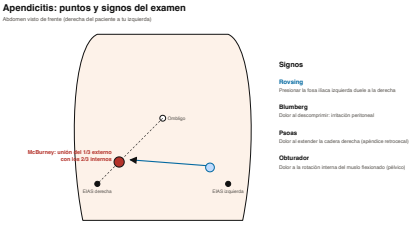
★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

1.06.2.001 **Abdomen agudo** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Apendicitis aguda · Enfermedad diverticular complicada

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Apendicitis**: dolor que migra del ombligo a la fosa ilíaca derecha + anorexia; diagnóstico clínico → apendicectomía.
- **Mujer en edad fértil con dolor abdominal bajo**: primero test de embarazo y evaluación ginecológica.
- **Plastrón apendicular (masa en FID)**: antibióticos primero y apendicectomía diferida; no es lo mismo que la apendicitis perforada.
- **Diverticulitis**: TAC de abdomen y pelvis; la colonoscopía está contraindicada en el episodio agudo.
- **Hinchey I–II (absceso)** → antibióticos ± drenaje; Hinchey III–IV (peritonitis) → operación de Hartmann.
- **Fístula colovesical (complicación de la diverticulitis)**: neumaturia e infecciones urinarias recurrentes.



MCBURNEY, ROVSING Y OTROS
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · ABDOMEN AGUDO: APENDICITIS Y DIVERTICULITIS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

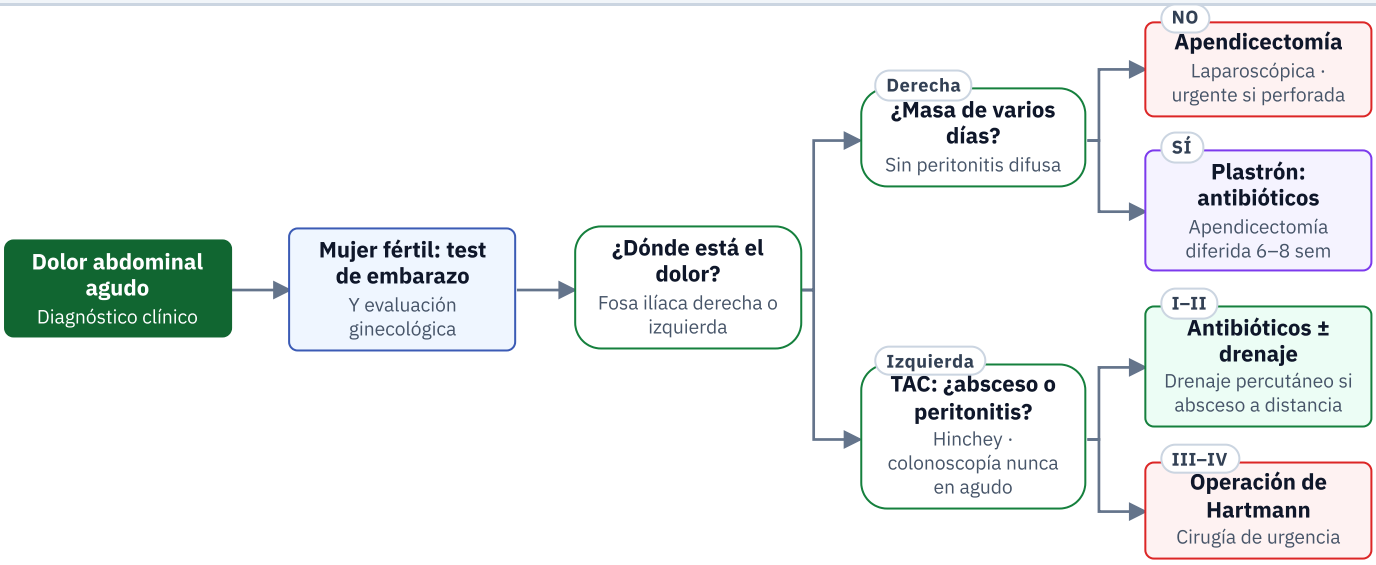


TABLA 5.1 · DIVERTICULITIS AGUDA — CLASIFICACIÓN DE HINCHEY Y CONDUCTA

HINCHEY	HALLAZGO EN EL TAC	TRATAMIENTO
I	Absceso pericólico pequeño	Antibióticos (± manejo ambulatorio en casos leves)
II	Absceso pélvico o a distancia	Antibióticos + drenaje percutáneo guiado por TAC
III	Peritonitis purulenta generalizada	Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)
IV	Peritonitis fecal (perforación libre)	Cirugía de urgencia (operación de Hartmann)
Post-episodio (6–8 sem)	—	Colonoscopía para descartar cáncer

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CUADRO	HALLAZGO CLAVE	CONDUCTA
Apendicitis aguda	Dolor que migra a la FID + anorexia	Apendicectomía laparoscópica
Plastrón apendicular	Masa en la FID, varios días	Antibióticos → apendicectomía a las 6–8 sem
Apendicitis perforada	Peritonitis difusa	Cirugía inmediata + lavado + antibióticos

REGLA DE ORO — **Mujer fértil: test de embarazo** — Antes de cualquier otra conducta

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **5, 22, 75, 77–78** (págs. 8, 10, 18) · solucionario págs. 20, 22, 29.

Clase 5.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS

5.2 Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

Rentabilidad media-alta · la "disociación clínica" en fibrilación auricular es un escenario recurrente

4.01.2.007 **Isquemia mesentérica aguda** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Abdomen agudo · Abdomen agudo en adulto mayor

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Embolia mesentérica**: fibrilación auricular + dolor súbito e intensísimo + abdomen sin signos peritoneales (disociación clínica).
- Ante la sospecha de embolia mesentérica se anticoagula con heparina de inmediato; el examen es la angio-TAC/angiografía.
- **Trombosis venosa mesentérica**: dolor subagudo con signos peritoneales, en hipercoagulables → TAC con contraste + anticoagulación.
- **Colitis isquémica**: dolor en el hemiabdomen izquierdo + hematoquecia en el adulto mayor; suele resolver con manejo médico.
- **Las tres**: hidratación + antibióticos; cirugía solo si hay necrosis o perforación.



ISQUEMIA INTESTINAL
Wikimedia Commons «Ischemicbowel.PNG», CC BY-SA 3.0, James Heilman, MD

ALGORITMO · DOLOR ABDOMINAL DESPROPORCIONADO AL EXAMEN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

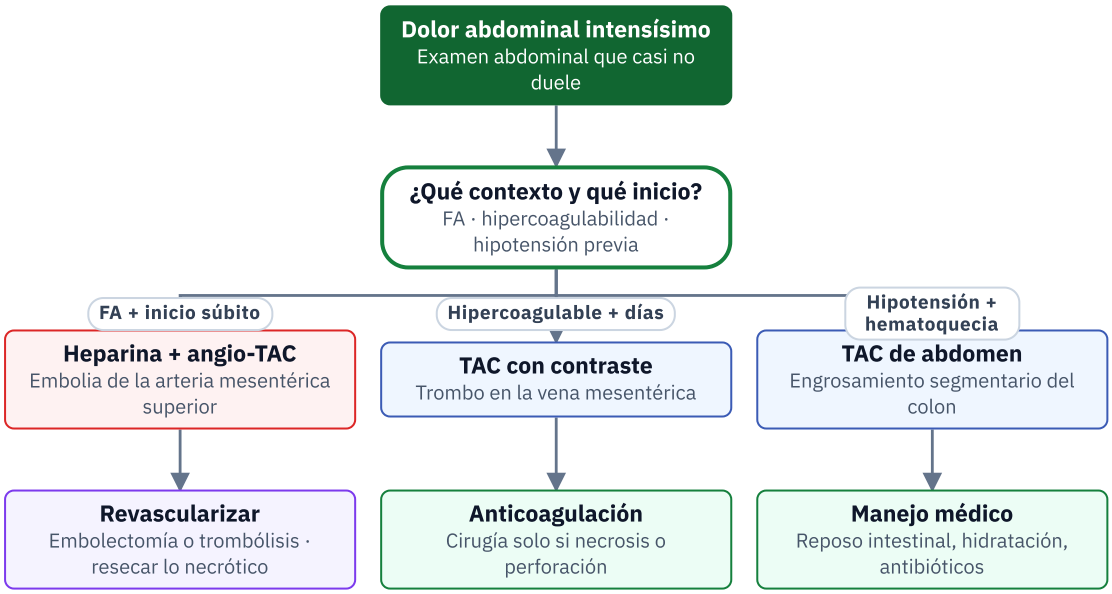


TABLA 5.2 · ABDOMEN AGUDO VASCULAR — LAS TRES ENTIDADES

ENTIDAD	INICIO / SIGNOS PERITONEALES	CONTEXTO	EXAMEN
Embolia mesentérica	Súbito / ausentes al inicio (disociación)	Fibrilación auricular	Angio-TAC / angiografía
Trombosis venosa mesentérica	Subagudo (días) / precoces	Hipercoagulabilidad, cirrosis	TAC con contraste
Colitis isquémica	Variable / según necrosis	Ateroesclerosis, hipotensión previa	TAC de abdomen

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ENTIDAD	PISTA CLÍNICA	EXAMEN Y CONDUCTA
Esperar el peritonismo en la embolia	Error clásico	Cuando aparece, el intestino ya se necrosó
Adulto mayor, dolor leve, sin fiebre ni leucocitosis	Abdomen agudo atípico	TAC de abdomen precoz; no esperar fiebre

REGLA DE ORO **FA + dolor súbito + abdomen blando** — Disociación clínica = embolia

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **79–80** (pág. 18) · solucionario pág. 30.

Clase 5.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS

5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja

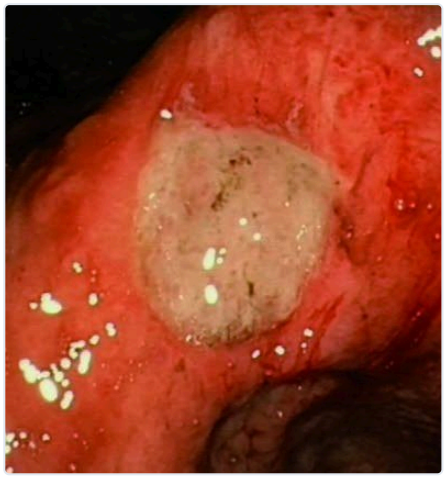
★★★ PRIORIDAD ALTA
16 preguntas reales 2013–2025

1.06.2.007 **Hemorragia digestiva alta y baja** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Endoscopía digestiva alta y baja · Tumores del intestino delgado · Hemorragia digestiva alta · Hemorragia digestiva

LO QUE TE PREGUNTAN

- La gravedad de una hemorragia digestiva se mide por la hemodinamia (taquicardia → ortostatismo → hipotensión), no por el hematocrito.
- **Reanimación inicial**: dos vías gruesas + cristaloides. La transfusión no es el primer paso.
- **Várices**: terlipresina + antibióticos + tiamina + ligadura. Úlcera: IBP endovenoso + terapia endoscópica.
- **Mallory-Weiss (vómitos y luego hematemesis)**: buen pronóstico, suele ser autolimitado.
- **HDB masiva que no se localiza en la colonoscopía** → endoscopía digestiva alta (**10 %** son en realidad altas).
- **Causa más frecuente de HDB masiva**: enfermedad diverticular. En el niño, divertículo de Meckel.



FONDO DE FIBRINA
Manual CTO Digestivo 14.ª ed., p. 63

ALGORITMO · SANGRADO DIGESTIVO: ESTABILIZAR PRIMERO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

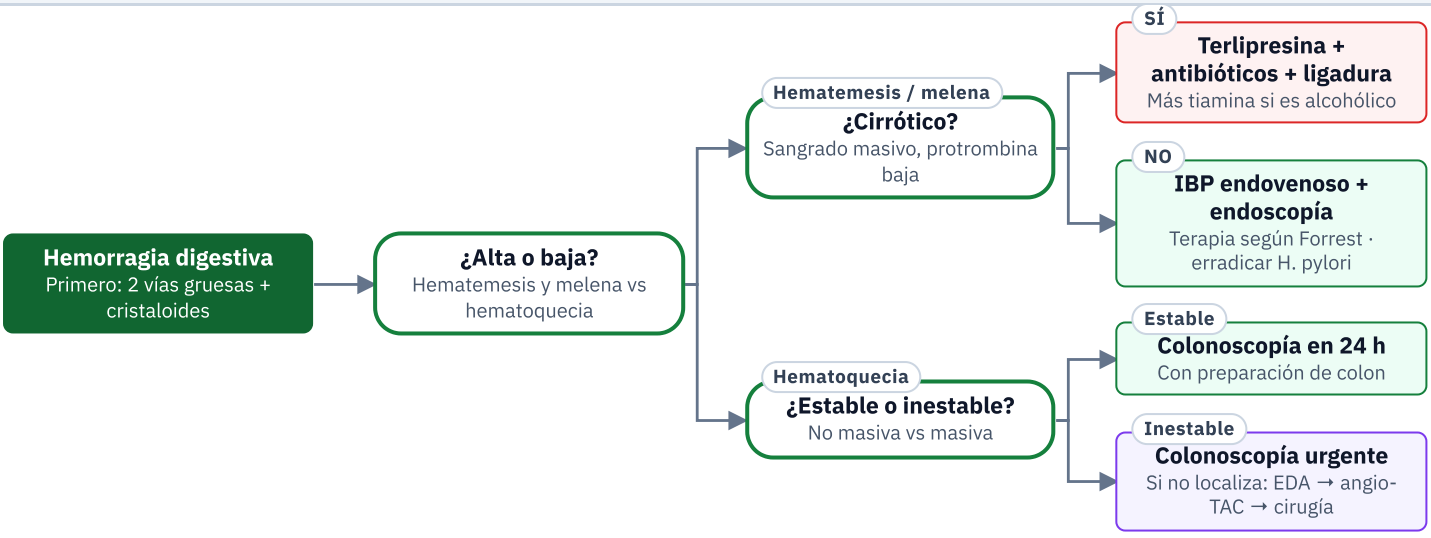


TABLA 5.3 · HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA — CAUSA Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO

CAUSA	PISTA CLÍNICA	ADEMÁS DEL SUERO Y LA ENDOSCOPÍA
Várices esofágicas	Cirrótico, sangrado masivo, protrombina baja	Terlipresina + antibióticos + tiamina
Úlcera gastroduodenal	Síndrome ulceroso previo, melena	IBP endovenoso en dosis alta; erradicar H. pylori
Mallory-Weiss	Vómitos alimentarios y luego hematemesis	Suele ser autolimitado; observar si está estable
Lesión de Dieulafoy / angiodisplasia	Sangrado recurrente sin lesión evidente	Hemostasia endoscópica

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	PISTA CLÍNICA	ADEMÁS DEL SUERO Y LA ENDOSCOPÍA
Taquicárdico con hematocrito normal	Hemorragia grave	Reanimar ya; no esperar el hematocrito
HDB masiva, colonoscopía sin hallazgos	Puede ser una HDA con tránsito rápido	Endoscopía alta, no laparotomía
Anemia o sangrado oculto con EDA y colonoscopía normales	Lesión o tumor del intestino delgado	Cápsula endoscópica o enteroscopía; derivar

REGLA DE ORO **Hemodinamia, no hematocrito** — Taquicardia, ortostatismo, hipotensión

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **76, 81–82** (pág. 18) · solucionario págs. 29–30.

Clase 5.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS

5.4 Cuerpo Extraño Digestivo

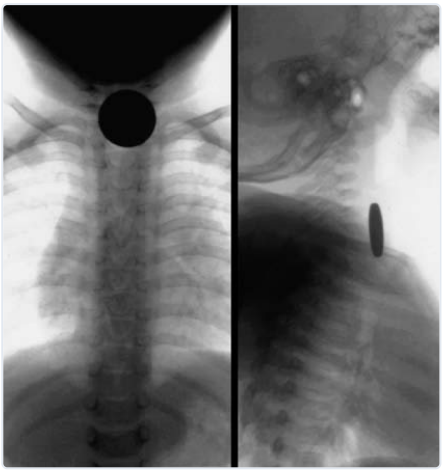
★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

6.03.2.008 Cuerpo extraño en el esófago — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Afagia aguda

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Sospecha de cuerpo extraño digestivo**: radiografía de cuello, tórax y abdomen.
- En el esófago se retira siempre por endoscopía; el dolor torácico sugiere perforación.
- **Pila de botón en el esófago** = emergencia (quemadura en horas) → extracción inmediata.
- **Se retira en cualquier ubicación**: pilas, **≥ 2 imanes**, objetos afilados o > **5 cm**, bolitas absorbentes.
- **Objeto romo y pequeño ya en el estómago, asintomático**: observar con radiografías cada **1–2 semanas**.
- **Alimento impactado**: observar **24 h** si tolera líquidos y no duele; endoscopía si no traga o tiene dolor.



MONEDA EN EL ESÓFAGO
Nelson 22.ª ed., p. 2925

ALGORITMO · CUERPO EXTRAÑO DIGESTIVO: ¿RETIRAR U OBSERVAR?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

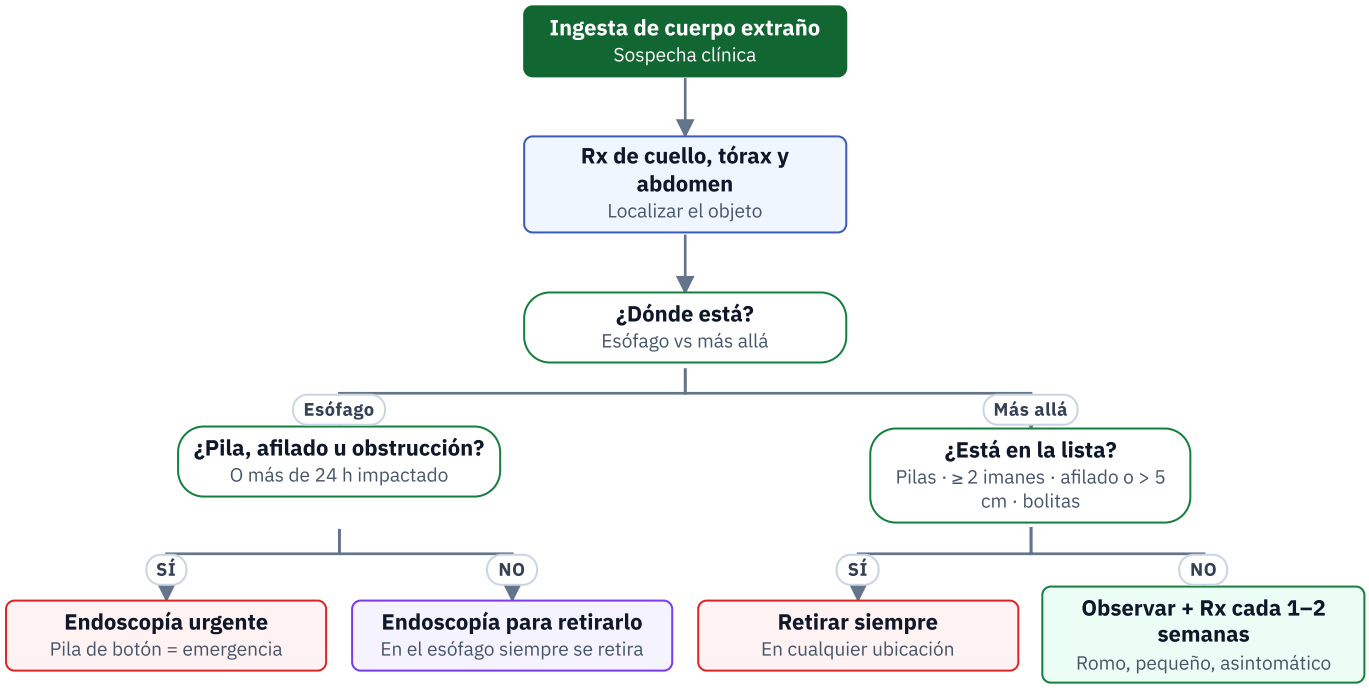


TABLA 5.4 · CUERPO EXTRAÑO DIGESTIVO — ¿RETIRAR U OBSERVAR?

SITUACIÓN	CONDUCTA
Cualquier cuerpo extraño en el esófago	Retiro endoscópico (urgente si obstrucción, pila o afilado)
Pila de botón en el esófago	Emergencia: extracción inmediata
Objeto romo y pequeño, ya en el estómago, asintomático	Observar + radiografía cada 1–2 semanas
Pilas, ≥ 2 imanes, objeto afilado o > 5 cm, bolitas absorbentes	Retirar siempre, en cualquier ubicación
Alimento impactado, tolera líquidos y sin dolor	Observar hasta 24 h
Alimento impactado con dolor o sin tragar líquidos	Endoscopía para desimpactar

REGLA DE ORO **Esófago: se retira siempre** — Pila de botón = emergencia

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **8, 83–84** (págs. 9, 19) · solucionario págs. 20, 30.

Clase 5.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 06 · GASTROENTEROLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA

6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño

Rentabilidad media · plan de hidratación pediátrico y descartar giardiasis antes que celíaca

★★★ PRIORIDAD ALTA
20 preguntas reales 2013–2025

2.01.1.039 **Diarrea aguda y en vías de prolongación** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Diarrea crónica · Deshidratación · Fibrosis quística · Enteroparasitosis · Parasitológico de deposiciones · Parasitosis intestinales

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Diarrea aguda del niño**: hidratar según el grado (Plan A oral / B SRO **50–100 mL/kg** / C suero fisiológico **20 mL/kg** en bolo).
- Antidiarreicos contraindicados en pediatría; antibiótico solo en disentería por Shigella o E. coli enteroinvasora (ciprofloxacino).
- **Salmonella no tifoidea no complicada**: no se trata con antibióticos (prolonga el estado de portador).
- **Diarrea crónica del lactante más frecuente**: diarrea crónica inespecífica por jugos hiperosmolares → suspender jugos.
- Siempre descartar giardiasis antes de diagnosticar enfermedad celíaca.
- **Alergia a la proteína de leche de vaca**: diagnóstico por prueba terapéutica con reintroducción; no hay test sanguíneo validado.



SIGNO DEL PLIEGUE
Wikimedia Commons «SkinTurgorExamination.jpg», CC BY-SA 4.0, DRobert

ALGORITMO · DIARREA EN EL NIÑO: HIDRATAR SEGÚN EL GRADO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

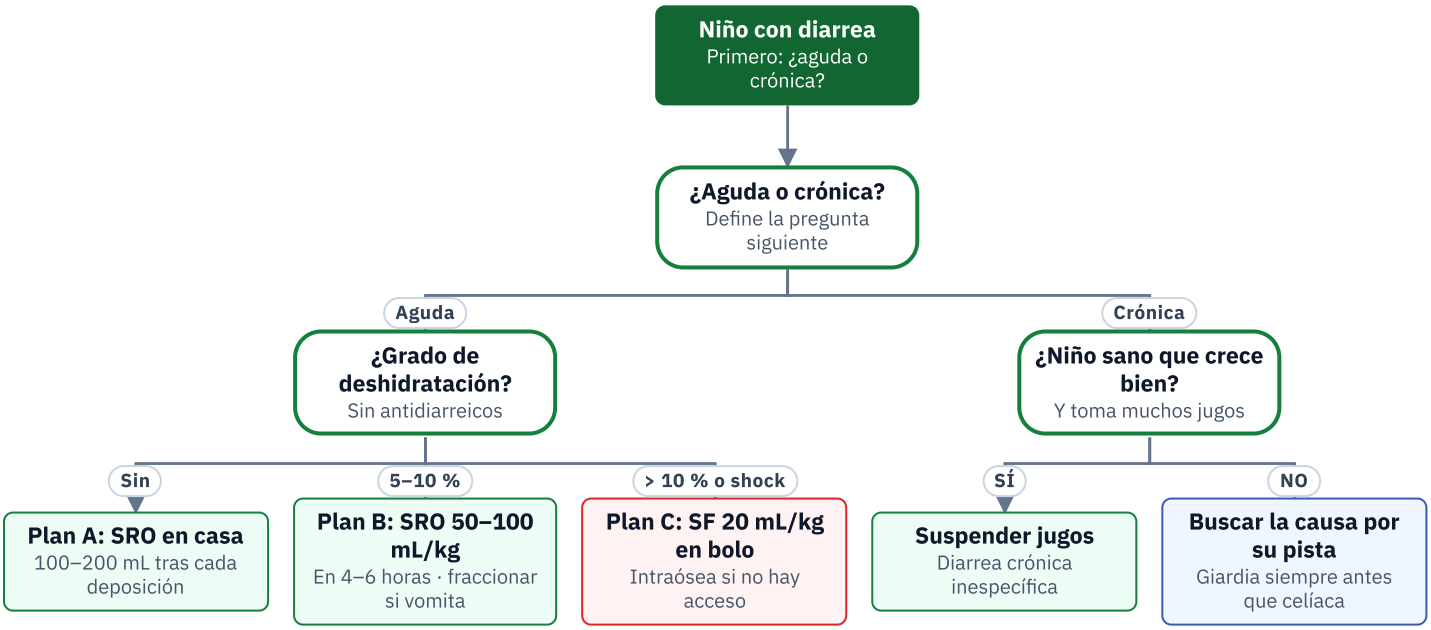


TABLA 6.1 · DIARREA CRÓNICA DEL LACTANTE — ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA

CAUSA	PISTA CLÍNICA	ESTUDIO / CONDUCTA
Diarrea crónica inespecífica	Niño sano que crece bien; bebe muchos jugos	Clínico → suspender jugos
Giardiasis	Zona rural, flatulencia, varios familiares afectados	Parasitológico seriado → tinidazol
Enfermedad celíaca	Malabsorción + anemia ferropénica desde el año	Anti-transglutaminasa + biopsia duodenal
Fibrosis quística	Esteatorrea + neumonías recurrentes	Test del sudor
Alergia a la proteína de leche de vaca	Síntomas GI + alérgicos en el lactante	Prueba terapéutica con fórmula hidrolizada

REGLA DE ORO **Plan según el grado** — A en casa · B SRO 50–100 mL/kg · C SF 20 mL/kg

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **25, 85–86** (págs. 11, 19) · solucionario págs. 23, 30–31.

Clase 6.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 06 · GASTROENTEROLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA

6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
10 preguntas reales 2013–2025

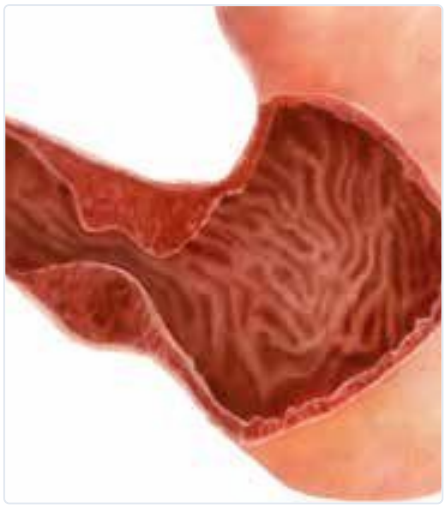
Rentabilidad media · el orden desimpactar-antes-de-mantener se pregunta con frecuencia

2.01.1.046	Displasia broncopulmonar / Reflujo gastroesofágico y vómitos del lactante (código repetido en el Perfil oficial)	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

También: Dolor abdominal recurrente · Constipación · Encopresis · Trastorno somatización en niños · Proctoclisis

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Reflujo del lactante fisiológico** = "lactante feliz" que crece bien → educar y tranquilizar, sin fármacos.
- Reflujo patológico (mal incremento, síntomas respiratorios, sangre): IBP (omeprazol) de primera línea.
- Vómitos explosivos entre la 2.ª y 6.ª semana + alcalosis hipoclorémica = estenosis hipertrófica del píloro → ecografía → pilorotomía de Ramstedt.
- **Dolor abdominal crónico sin signos de alarma**: funcional/psicógeno, periumbilical, ligado al estrés escolar.
- El fecaloma es la causa más frecuente de masa abdominal en pediatría (encopresis, pseudoincontinencia).
- **Constipación con fecaloma**: primero desimpactar (polietilenglicol oral), después mantener con laxante **≥ 4 semanas**.



MÚSCULO PILÓRICO ENGROSADO
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 65

ALGORITMO · EL LACTANTE QUE VOMITA O REGURGITA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

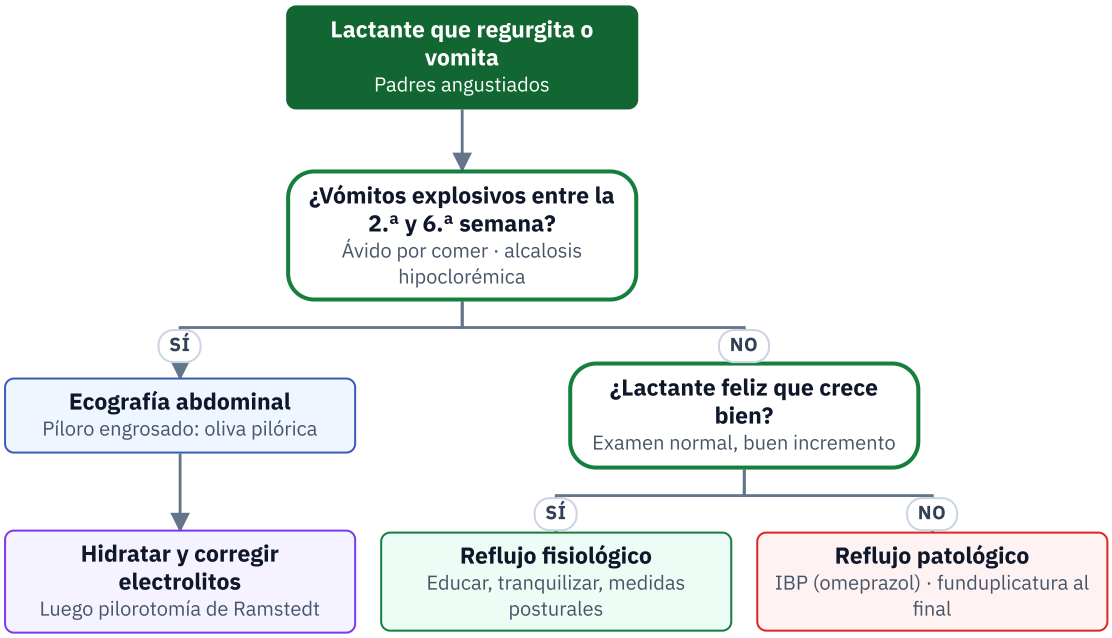


TABLA 6.2 · REFLUJO DEL LACTANTE: FISIOLÓGICO VS PATOLÓGICO

RASGO	FISIOLÓGICO	PATOLÓGICO
Estado del lactante	"Lactante feliz"	Irritable, rechazo alimentario
Incremento ponderal	Normal	Enlentecido o descenso
Síntomas respiratorios / sangre	Ausentes	Presentes
Conducta	Educar y tranquilizar	Estudiar + IBP (omeprazol)

REGLA DE ORO **Lactante feliz que crece bien** — Reflujo fisiológico: educar, sin fármacos

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **87–88** (pág. 19) · solucionario pág. 31.

Clase 6.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 06 · GASTROENTEROLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA

6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
11 preguntas reales 2013–2025

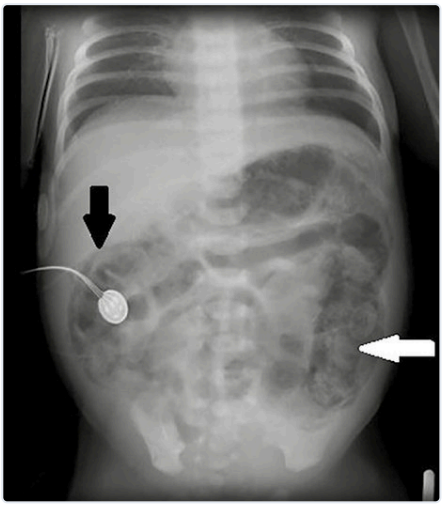
Rentabilidad media · cada entidad tiene una imagen-clave única que resuelve la pregunta

2.01.1.116 **Enterocolitis necrotizante (ECN)** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Obstrucción intestinal · Divertículo de Meckel · Malformaciones congénitas más frecuentes · Megacolon · Radiografía de abdomen simple · Radiografía esófago-estómago- duodeno · Enema barritada

LO QUE TE PREGUNTAN

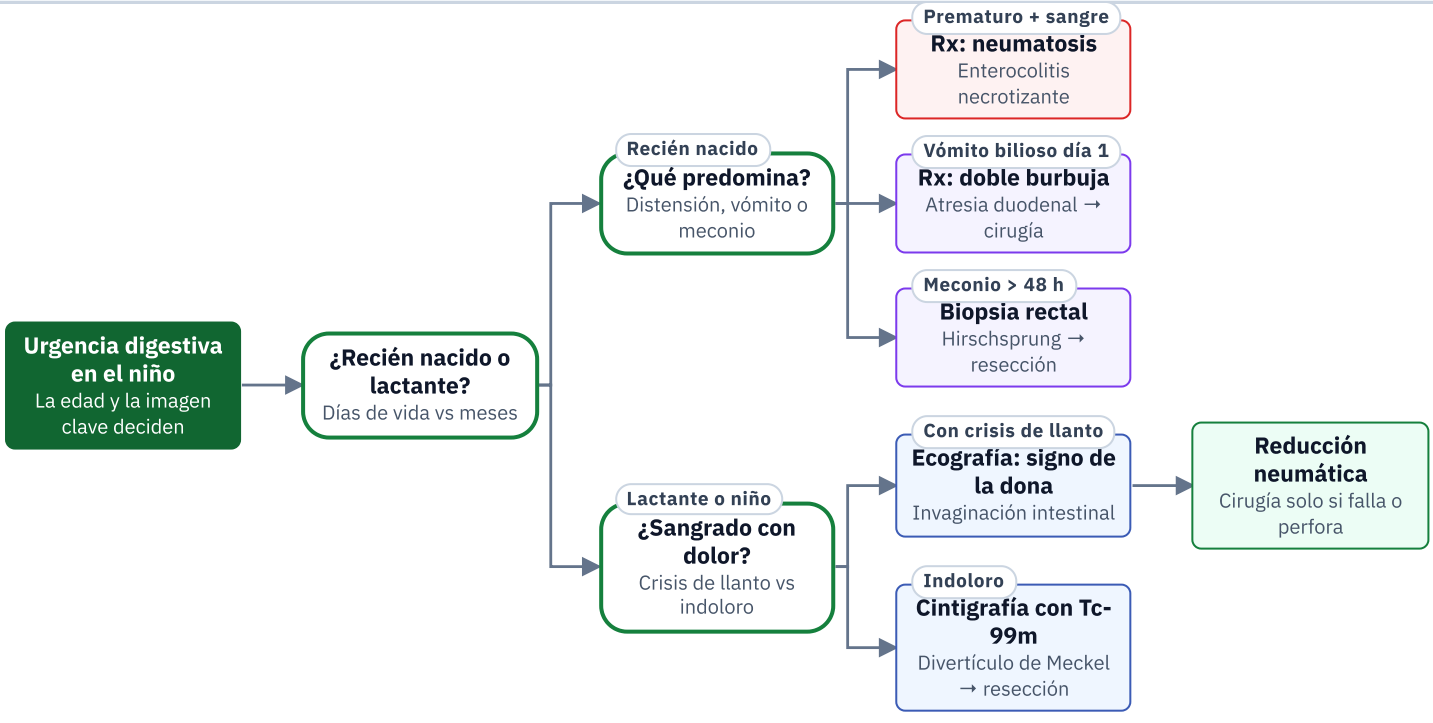
- Prematuro + tríada (retención, distensión, hematoquecia) + neumatosis intestinal = enterocolitis necrotizante.
- Lactante **6–12 meses** + llanto en crisis + "mermelada de grosella" = invaginación → reducción neumática de primera línea.
- **Hemorragia digestiva baja indolora y abundante en un niño** = divertículo de Meckel → cintigrafía con Tc-99m.
- Vómito bilioso el primer día de vida + "doble burbuja" en la radiografía = atresia duodenal.
- **Retraso en la eliminación del meconio (> 48 h)** = enfermedad de Hirschsprung → biopsia rectal.
- **Hernia diafragmática congénita**: lo urgente es intubar y ventilar; la reparación quirúrgica es diferida.



NEUMATOSIS INTESTINAL
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 24

ALGORITMO · URGENCIAS QUIRÚRGICAS DIGESTIVAS DEL RN Y EL LACTANTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **89–90** (pág. 19) · solucionario pág. 31.

Clase 6.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 06 · GASTROENTEROLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA

6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 6.3 · CIRUGÍA PEDIÁTRICA DIGESTIVA — CLAVE DIAGNÓSTICA ÚNICA

ENTIDAD	CLAVE	CONDUCTA
Enterocolitis necrotizante	Prematuro + neumatosis intestinal en la Rx	Régimen cero + NPT + antibióticos; cirugía si perfora
Invaginación intestinal	Lactante 6–12 m + "mermelada de grosella" + signo de la dona	Reducción neumática (cirugía si falla)
Divertículo de Meckel	HDB indolora y abundante en niño pequeño	Cintigrafía con Tc-99m → resección
Atresia duodenal	Vómito bilioso día 1 + doble burbuja	Cirugía
Enfermedad de Hirschsprung	Meconio > 48 h + constipación	Biopsia rectal → resección
Hernia diafragmática congénita	Distrés respiratorio + abdomen excavado	Intubar y ventilar; cirugía diferida

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ENTIDAD	CLAVE	CONDUCTA
Malrotación con vólvulo	Vómito bilioso + duodeno que no cruza la línea media	Rx esófago-estómago-duodeno urgente; cirugía

REGLA DE ORO **Prematuro + neumatosis** — Enterocolitis: tratamiento médico, cirugía si perfora

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

Este tema se estudia por sus imágenes-clave, una por diagnóstico. Neumatosis intestinal en un prematuro = enterocolitis necrotizante. Lactante de 6–12 meses con llanto en crisis y deposiciones "en mermelada de grosella" = invaginación. Sangrado rectal indoloro y abundante en un niño sano = divertículo de Meckel. Doble burbuja en el recién nacido que vomita desde el primer día = atresia duodenal. Meconio que no sale en 48 horas = enfermedad de Hirschsprung.

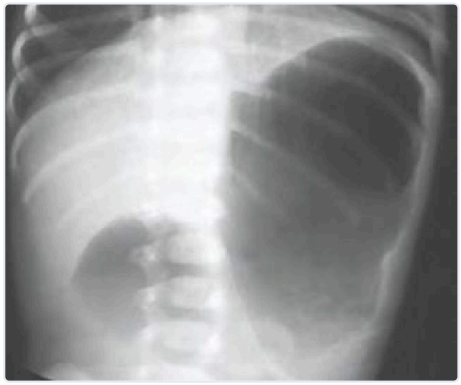
ASÍ SE VE · FOTOS DE LA CLASE



SIGNO DE LA DONA
Manual CTO Pediatría 14.ª ed., p. 70



INVAGINACIÓN (ESQUEMA)
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 155



DOBLE BURBUJA
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 9.24

PRACTICA **Libro Gordo Gastroenterología**, preguntas **89–90** (pág. 19) · solucionario pág. 31.

Clase 6.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 06 · GASTROENTEROLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA

6.4 Trauma Abdominal y Torácico

Rentabilidad media · el mecanismo (cerrado / arma blanca / arma de fuego) decide la conducta

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
7 preguntas reales 2013–2025

4.01.2.010 Trauma abdominal abierto y cerrado — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Traumatismo torácico grave · Neumotórax hipertensivo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Trauma abdominal cerrado**: clínica + eco-FAST; estable con FAST negativa → observación. El lavado peritoneal está obsoleto.
- **Trauma abdominal por arma blanca**: si la herida penetra el peritoneo → exploración quirúrgica.
- **Trauma abdominal por arma de fuego**: exploración quirúrgica siempre.
- **Víscera hueca rota** → peritonitis y neumoperitoneo; víscera sólida (bazo, hígado) → hemoperitoneo, manejo conservador si está estable.
- **Trauma torácico**: clínica + radiografía; hemotórax > **1.500 mL** inicial o > **200 mL**/h → toracotomía. Arma de fuego torácica → cirugía.



FAST POSITIVO
ATLS 10.ª ed., p. 144

ALGORITMO · TRAUMA DE ABDOMEN Y TÓRAX: MANDA EL MECANISMO

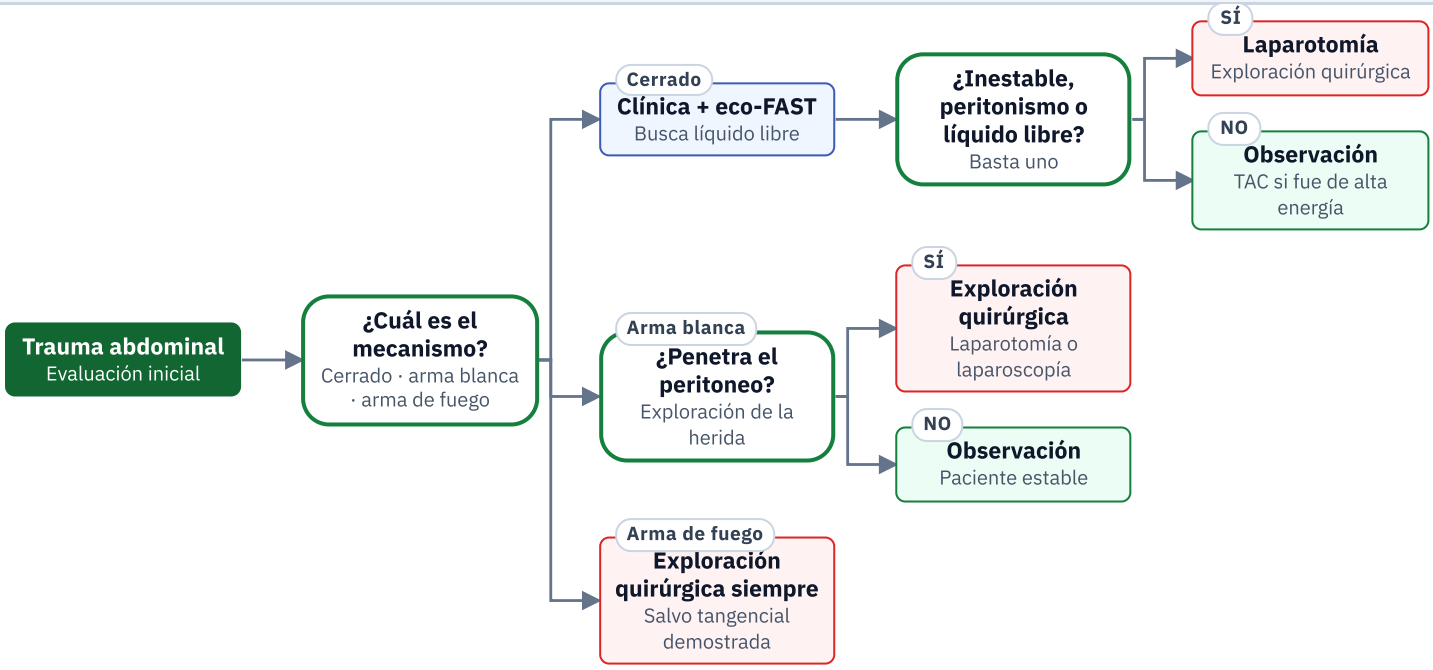


TABLA 6.4 · TRAUMA DE ABDOMEN — CONDUCTA SEGÚN EL MECANISMO

MECANISMO	EVALUACIÓN	CIRUGÍA SI...
Cerrado	Clínica + eco-FAST (± TAC)	Inestable, signos peritoneales o líquido libre
Arma blanca	Clínica + exploración de la herida	Penetra el peritoneo, inestable, peritonitis o evisceración
Arma de fuego	Clínica	Siempre (salvo herida tangencial demostrada)

REGLA DE ORO — **Cerrado: clínica + eco-FAST** — Estable y FAST (–): observar

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Gastroenterología**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 6.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 26 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · ESÓFAGO Y ESTÓMAGO	
1.1 Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett	pág. 3
Pirosis típica, < **50 años**, sin alarma · Prueba con IBP **4–8 semanas**	CORTE
IBP en ayunas — **30 a 60 minutos** antes del desayuno	TIEMPO
1.2 Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori	pág. 4
40 años o más — Descartar cáncer gástrico (GES)	CORTE
Sin erradicación, la úlcera recidiva en el **90 %**.	CORTE
Triple terapia por **14 días** — Si falla: cuádruple con bismuto	TIEMPO
1.4 Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico	pág. 6
EDA en las primeras **12–24 h** — Gradúa el daño y decide la conducta	TIEMPO
1.6 Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino	pág. 8
Hernia hiatal tipo I (deslizamiento, > **95 %**): casi normal; se observa y solo se trata el reflujo si existe.	CORTE
BLOQUE 02 · INTESTINO Y COLON	
2.1 Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable	pág. 9
Dolor **≥ 1 día** por semana — En los últimos **3 meses**	CORTE
2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación	pág. 10
Viajero, fiebre > **2–3 días** o sepsis — Las otras tres indicaciones	CORTE
Aguda < 2 sem · prolongada 2–4 · crónica **≥ 4** — El tiempo clasifica	CORTE
A · Sin deshidratación (< **5 %** pérdida de peso) · SRO **100–200 mL** post deposición, en casa	DOSIS
B · Deshidratación moderada (**5–10 %**): irritable, mucosas secas, ojos hundidos · SRO **50–100 mL/kg** en **4–6 h** y reevaluar	DOSIS
2.4 Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn	pág. 12
Líquido-pastoso: **500 a 1.000 mL** al día — Más de **1.500 mL** es alto débito	DOSIS
Desde el recto, continua — Rectitis en el **100 %**, sin mucosa sana intercalada	CORTE
Colitis ulcerosa: riesgo de megacolon tóxico y de cáncer colorrectal tras **8–10 años** (vigilancia colonoscópica).	CORTE
2.5 Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje	pág. 13
Sangre oculta inmunoquímico — O colonoscopía cada **10 años**	CORTE
2.6 Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula	pág. 14
Nódulo violáceo doloroso — Trombectomía solo dentro de **48–72 h**	TIEMPO
Baños de asiento + tratar constipación — Crónica > **6 semanas**: esfinterotomía lateral interna	CORTE
BLOQUE 03 · HÍGADO	
3.1 Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico	pág. 15
Sobrevida a **5 años** menor de **10 %** — Sospechar, estudiar y derivar sin demora	CORTE
3.2 Hepatitis Aguda y Crónica	pág. 16
Relación AST/ALT > 2 = hepatitis alcohólica.	CORTE
AST/ALT > 2, ambas < 300–400 — Más GGT y VCM elevados	CORTE
Antivirales de acción directa — **8–12 semanas** · curación > **95 %**	CORTE
3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal	pág. 17
Evacuadora: albúmina si más de **5 L** — **6 a 8 g** por litro	DOSIS
Líquido ascítico con **≥ 250 PMN/mm³** · Cefotaxima + albúmina	CORTE
El gradiente albúmina suero-ascitis **≥ 1,1 confirma** hipertensión portal.	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares	pág. 18
Adenoma: resecar si > **5 cm** — Y suspender estrógenos	CORTE
Colelitiasis antigua, porcelana, pólipo mayor de **1 cm** — Chile: incidencia de las más altas; predomina en mujeres	CORTE
BLOQUE 04 · VÍA BILIAR Y PÁNCREAS	
4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis	pág. 19
Pared > **4 mm** — Y líquido perivesicular	CORTE
Colecistitis: cirugía < **72 h** — La única que se opera de urgencia	CORTE
Entre 35 y **49 años** — Colecistectomía garantizada	CORTE
4.2 Pancreatitis Aguda	pág. 20
Triglicéridos > **1000 mg/dL** — También hipercalcemia y fármacos	DOSIS
Lipasa o amilasa > **3 veces** — Sobre el límite superior normal	CORTE
Dolor + lipasa > **3×**: basta — Sin TAC; TAC a las **72 h** si evoluciona mal	CORTE
BLOQUE 05 · ABDOMEN AGUDO Y URGENCIAS DIGESTIVAS	
5.1 Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis	pág. 21
A las **6–8 semanas** — Para descartar cáncer	TIEMPO
Mayor de **50 años** — El paciente es distinto	CORTE
5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja	pág. 23
Ligadura endoscópica — En las primeras **12 horas**	TIEMPO
5.4 Cuerpo Extraño Digestivo	pág. 24
Pilas, **≥ 2 imanes**, afilados o > **5 cm**, bolitas — Se retiran siempre	CORTE
Romo en el estómago: observar — Rx cada **1–2 semanas**	TIEMPO
BLOQUE 06 · GASTROENTEROLOGÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA	
6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño	pág. 25
Test del sudor — Cloro **≥ 60 mmol/L** confirma	CORTE
Plan según el grado — A en casa · B SRO **50–100 mL/kg** · C SF **20 mL/kg**	DOSIS
6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño	pág. 26
Decúbito lateral izquierdo, rodillas flexionadas — Sonda lubricada **3 a 5 cm**	CORTE
6.3 Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones	pág. 27
Meconio > **48 h** — Hirschsprung: biopsia rectal	CORTE
Zona de transición en cono — Retención de bario a las **24 horas**	TIEMPO
6.4 Trauma Abdominal y Torácico	pág. 29
> **200 mL**/h por **2–4 horas** — Débito sostenido	DOSIS
> **1.500 mL** inicial o > **200 mL**/h — Hemotórax masivo	DOSIS

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
1.1 Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett		pág. 3
Inhibidor de la bomba de protones	**Omeprazol en ayunas**	**30 a 60 minutos** antes del desayuno
1.2 Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori		pág. 4
Erradicación · Primera línea	**IBP + amoxicilina + claritromicina**	Amoxicilina **1 g** y claritromicina **500 mg**, cada **12 horas**
Erradicación · Segunda línea	**Cuádruple con bismuto**	IBP + bismuto + tetraciclina + metronidazol
AINE · Uso seguro	**Paracetamol si el dolor es leve**	
AINE · Uso seguro	**AINE + IBP en el paciente de riesgo**	No sirven anti-H2 ni sucralfato
1.3 Disfagia y Trastornos Motores del Esófago		pág. 5
Abrir el esfínter	**Toxina botulínica**	Etapas iniciales o no operables
Abrir el esfínter	**Bloqueadores de calcio**	Relajan el EEI, pero dan reflujo
1.4 Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico		pág. 6
Cirugía de urgencia	**Suero, IBP ev, antibióticos**	Complementos, no reemplazo
1.5 Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico		pág. 7
Tumores gástricos benignos · Endoscopía y derivar	**GIST: cirugía; imatinib si es de alto riesgo**	c-KIT positivo; todo tumor se deriva
1.6 Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino		pág. 8
Según la causa	**Linfoma: quimioterapia**	Teratoma maduro: resección
2.1 Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable		pág. 9
Según el síntoma que predomina	**Dolor: antiespasmódicos**	Trimebutino, bromuro de pinaverio
Según el síntoma que predomina	**Diarrea: amitriptilina en dosis baja**	Antidepresivo tricíclico
Según el síntoma que predomina	**Constipación: polietilenglicol**	Laxante osmótico
2.2 Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación		pág. 10
Adulto	**Ciprofloxacino oral**	Ceftriaxona EV si es grave
Adulto · Cólera o Campylobacter	**Azitromicina**	
Parasitosis intestinales del adulto · Protozoos	**Giardia: tinidazol o metronidazol**	Tinidazol **2 g** en dosis única
Parasitosis intestinales del adulto · Protozoos	**Entamoeba: metronidazol y amebicida luminal**	Disentería y absceso hepático
2.4 Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn		pág. 12
Base	**5-ASA: mesalazina, sulfasalazina**	Tópico + oral según extensión
Escalones superiores	**Inmunomoduladores**	Azatioprina, metotrexato
Escalones superiores	**Biológicos**	Anti-TNF: infliximab, adalimumab; vedolizumab, ustekinumab
3.2 Hepatitis Aguda y Crónica		pág. 16
Manejo y contactos	**Exposición reciente: IgHB + vacuna**	Contactos: vacuna
Manejo y contactos · RN de madre AgHBs +	**Vacuna + IgHB < 12 h · lactancia sí**	
Casi siempre crónica, hoy curable · Garantizado	**Antivirales de acción directa**	**8–12 semanas** · curación > **95 %**
3.3 Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal		pág. 17
Profilaxis · Profilaxis primaria	**Betabloqueo no selectivo**	Propranolol o carvedilol

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño (cont.)		pág. 26
No complicada	**Espironolactona ± furosemida**	Diuréticos
Buscar el precipitante · Dos pasos	**Lactulosa: 2–3 deposiciones blandas al día**	+ rifaximina
Dieta y cuidados del cirrótico · Ante una descompensación	**Vacunas, evitar AINE y sedantes**	Hepatitis A y B, neumococo, influenza
3.4 Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares		pág. 18
Quiste, hidatídico o absceso · Absceso hepático	**Amebiano: metronidazol**	Piógeno: antibióticos + drenaje
4.1 Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis		pág. 19
Cólico biliar · En urgencia	**Dipirona + antiespasmódico**	Analgesia
4.2 Pancreatitis Aguda		pág. 20
Analgesia, nutrición y antibióticos · Analgesia	**Opioides**	La meperidina ya no se prefiere
Pancreatitis crónica · Médico general	**Enzimas pancreáticas con cada comida**	Vitaminas liposolubles y B12; insulina si hay diabetes
5.1 Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis		pág. 21
Pabellón · Perforada: urgencia	**Cirugía + lavado + antibióticos**	
La base	**Ceftriaxona + metronidazol**	Endovenosos u orales según la gravedad
5.3 Hemorragia Digestiva Alta y Baja		pág. 23
Várices esofágicas · Además del suero	**Terlipresina**	Baja la presión portal
Várices esofágicas · Además del suero	**Antibióticos**	Profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea
Várices esofágicas · Además del suero	**Tiamina si es alcohólico**	No olvidarla
Úlcera gastroduodenal	**IBP endovenoso en dosis alta**	Terapia endoscópica según Forrest
6.1 Diarrea Aguda y Crónica en el Niño		pág. 25
Fibrosis quística · Derivar	**Vitaminas A, D, E y K; dieta hipercalórica con sal**	Kinesioterapia respiratoria y vacunas al día
6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño		pág. 26
Constipación · Fase 1	**Polietilenglicol oral**	De elección; alternativa: enema
Constipación · Fase 2	**Laxante osmótico, al menos 4 semanas**	Para romper el círculo
Encopresis · Conductual	**Desimpactar y laxante**	Como en la constipación

GES de Gastroenterología

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Endoscopía digestiva alta en ≥ 40 años con dispepsia/signos de alarma**

Tema **1.5** · Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico
`1.06.1.004` · `4.01.1.005` · `1.06.3.003`
pág. **7**

GES **Tamizaje de cáncer de colon (sangre oculta inmunoquímico) desde los 50 años**

Tema **2.5** · Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje
`1.06.1.029` · `4.01.1.014` · `4.01.1.015`
pág. **13**

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Hepatitis crónica por virus B y C (estudio y antivirales garantizados)**

Tema **3.2** · Hepatitis Aguda y Crónica
`1.06.1.019` · `1.06.1.020` · `1.06.1.021`
pág. **16**

GES **Colecistectomía preventiva en colelitiasis, 35 a 49 años**

Tema **4.1** · Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis
`1.06.1.006` · `1.06.2.004` · `1.06.2.003`
pág. **19**

Sin garantía GES específica (22 temas): 1.1 · 1.2 · 1.3 · 1.4 · 1.6 · 2.1 · 2.2 · 2.3 · 2.4 · 2.6 · 3.1 · 3.3 · 3.4 · 4.2 · 5.1 · 5.2 · 5.3 · 5.4 · 6.1 · 6.2 · 6.3 · 6.4. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

5 temas · ★★★

- ★★★ **2.4** Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn 12
- ★★★ **2.2** Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación 10
- ★★★ **3.1** Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico 15
- ★★★ **6.1** Diarrea Aguda y Crónica en el Niño 25
- ★★★ **4.1** Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis 19

Practica: Libro Gordo Gastroenterología, preguntas 1, 3, 20, 23, 25, 28, 31–32, 35–36, 38, 49–50, 58–64, 66–67, 69–70, 73, 85–86.

DÍA 2

5 temas · ★★★

- ★★★ **5.3** Hemorragia Digestiva Alta y Baja 23
- ★★★ **2.3** Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa 11
- ★★★ **5.1** Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis 21
- ★★★ **1.4** Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico 6
- ★★☆ **1.2** Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori 4

Practica: Libro Gordo Gastroenterología, preguntas 5, 7, 11–12, 15–16, 21–22, 24, 26, 33–34, 74–78, 81–82.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **3.4** Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares 18
- ★★☆ **1.3** Disfagia y Trastornos Motores del Esófago 5
- ★★☆ **3.2** Hepatitis Aguda y Crónica 16
- ★★☆ **2.5** Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje 13

Practica: Libro Gordo Gastroenterología, preguntas 4, 13–14, 27, 39–41, 43, 45–46, 51–53, 55–57.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **3.3** Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal 17
- ★★☆ **6.3** Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones 27
- ★★☆ **6.2** Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño 26
- ★★☆ **1.1** Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett 3

Practica: Libro Gordo Gastroenterología, preguntas 6, 9–10, 37, 42, 44, 47–48, 54, 87–90.

DÍA 5

4 temas · ★★

- ★★☆ **4.2** Pancreatitis Aguda 20
- ★☆☆ **6.4** Trauma Abdominal y Torácico 29
- ★☆☆ **1.5** Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico 7
- ★☆☆ **2.6** Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula 14

Practica: Libro Gordo Gastroenterología, preguntas 2, 17–18, 65, 68, 71–72.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **5.2** Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular 22
- ★☆☆ **2.1** Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable 9
- ★☆☆ **5.4** Cuerpo Extraño Digestivo 24
- ★☆☆ **1.6** Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino 8

Practica: Libro Gordo Gastroenterología, preguntas 8, 19, 29–30, 79–80, 83–84.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 30
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 1.4 · 2.2 · 2.3 · 2.4 · 3.1 · 4.1 · 5.1 · 5.3 · 6.1
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Gastroenterología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 9 temas

22 2.4. Enfermedad Inflamatoria Intestinal: Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn 12
20 2.2. Diarrea Aguda, Diarrea Crónica y Constipación 10
20 3.1. Ictericia y Colestasia: Enfrentamiento Diagnóstico 15
20 6.1. Diarrea Aguda y Crónica en el Niño 25
19 4.1. Colelitiasis, Colecistitis, Coledocolitiasis y Colangitis GES 19
16 5.3. Hemorragia Digestiva Alta y Baja 23
15 2.3. Síndrome de Malabsorción, Enfermedad Celíaca e Intolerancia a la Lactosa 11
15 5.1. Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis 21
14 1.4. Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáustico 6

★★ Prioridad media · 10 temas

13 1.2. Úlcera Péptica, Dispepsia Funcional y Helicobacter pylori 4
13 3.4. Lesiones Hepáticas Focales y Pólipos Vesiculares 18
12 1.3. Disfagia y Trastornos Motores del Esófago 5
12 3.2. Hepatitis Aguda y Crónica GES 16
11 2.5. Pólipos y Cáncer Colorrectal · Tamizaje GES 13
11 3.3. Daño Hepático Crónico e Hipertensión Portal 17
11 6.3. Cirugía Pediátrica Digestiva: Urgencias y Malformaciones 27
10 6.2. Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño 26
9 1.1. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico y Esófago de Barrett 3
9 4.2. Pancreatitis Aguda 20

★ Prioridad baja · 7 temas

7 6.4. Trauma Abdominal y Torácico 29
4 1.5. Cáncer de Esófago y Cáncer Gástrico GES 7
4 2.6. Patología Perianal: Fisura, Hemorroides, Absceso y Fístula 14
3 5.2. Isquemia Mesentérica y Abdomen Agudo de Origen Vascular 22
2 2.1. Trastornos Digestivos Funcionales y Síndrome de Intestino Irritable 9
1 5.4. Cuerpo Extraño Digestivo 24
0 1.6. Hernia Hiatal, Hernia Diafragmática y Tumores del Mediastino 8